

La Pré-Eclampsie

C'est l'association d'une hyper tension artérielle gravidique et d'une protéinurie 3g/24h ou $>$ à 2 croix à la CU.

Mais la protéinurie des 24h est initialement (–) cependant il faut rechercher les signes suivants :

.**œdèmes** d'apparition brutale ou aggravés

.**hyperuricémie** 350 μ mol /l **nb** : une uricémie élevée est un signe de début d'insuffisance rénale et de souffrance placentaire

.**cytolyse hépatique**

.**thrombopénie** 150 000 éléments/mm

.**retard de croissance intra-utérin** (RCIU)

La pré-éclampsie sévère

Si un ou plusieurs signes suivants sont présents ;

.**TA** $>$ 16/11

.**Douleurs** épigastriques, nausées, vomissements.

.**Céphalées** persistantes, troubles visuels (phosphènes)

.**Protéinurie** $>$ 3.5g/l

.**Oligurie**, creat $>$ 100 μ mol/l

.**Thrombopénie** $<$ 100 000/mm³

.**Cytolyse hépatique** : 3x la normale

HELLP syndrome :

H : hémolyse (HB diminué, LDH élevé et présence de Schizocytes au frottis sanguin)

EL : Elevated Liver enzyme cytolysis hépatique (TGO $\uparrow$ TGP)

LP : 'Low platelets' thrombopénie 100 000 ele/mm³

HTA gravidique ^{نظ}

C'est l'existence chez une femme enceinte > 20 SA d'une
TA > 14/9 sans **protéinurie**

Bilan d'HTA

.FNS, TP, Fibrinémie
.Bilan rénal (urée, creat)
.Bilan hépatique (Asat, Alat)
.Albumine
.Protides totaux
.Acide urique -Ionogramme
.glycémie
.Protéinurie des 24h

C.A.T devant un pic hypertensif **chez une femme enceinte**

- **>14/9**
- Repos----- refaire la prise tensionnelle
- Si touj **> 14/9** ----- 1 cc de **Loxen** dilué dans 3cc de SSI + C.U
- Si stabilisation : .Bilan d'HTA + profil tensionnel
biquotidien
.Surveillance des signes de pré-éclampsie
.Protéinurie des 24 h

Exagération des signes sympathiques

- Apprécier l'état général et l'état d'hydratation de la malade
- Si une hospitalisation est indiquée
 - .FNS
 - .Ionogramme
 - .Taux de **B-HCG**
 - .TSH, T3, T4
- Schémas de réhydratation :
 - .SSI + Kcl 1g + primperan
 - .SGI +Nacl 1g + Kcl 1g + prinperan
 - .SSI
 - .SGI
- 1 amp d'**Azantac**
- Largactil** gttes 5 gttes le soir
- Omeprazol** gel 20mg (1gel/j) / **Gaviscon** sirop / **Vogalene**
C.A.T devant un Col Défavorable (fermé) avec un dépassement de terme
- Spasfon** supp : 1 supp x 4 en cas de douleur
- Ovestin** ovule 1 ovule x 2/j
- Spasfon** à usage hospitalier (injectable)
- Amoxicilline** cp 1 g 1cp x 3/j

C.A.T devant une activité cardiaque(-)^{ve}

< 28 SA ∩

-On parle de :
'Grossesse arrêtée'
(Coté gynécologie)

- .**Methergin** gouttes ----1 Bte
25 gttes x 2/j
- .**Methergin** ovules -----1 Bte
1 ovule / j
- .**Spasfon** supp -----1 Bte
1 supp x 4/j

>28 SA

-On parle de :
--mort in-utéro--
(Coté GHR)

- .On Déclanche :
. **Methergin**
30 gttes x 3/j
ou .**Synto** 1 inj /j IM

C.A.T devant une infection vaginale

Leucorrhées

Blanchâtres Verdâtres Jaunâtres Transparentes

.on donne un antiseptique en attendant le résultat de l'ECB du prélèvement vaginal afin d'être efficace ; mais en gros ; on peut s'orienter vers le germe responsable par la couleur des leucorrhées.

1-Blanchatres : «Mycose» (candida albicans)

-**Fluconazole** gel 150mg 1gel en une prise a renouveler après 2 sem.

-**Polygynax** ovule : 1 a2 ovules /j pdt 10j ou ovule cp 150 : 1 ovule unique

-**Lotion alcaline** : **Dermobacter** ou **Saforelle**.

-Traiter le partenaire 1f

2-Verdatres « trichomonas vaginalis »

-**Tergynan** ovule : 2ovules/j pdt 10 jours

-**Flagyl** cp 500mg : 04 cp en peros en une seule prise

-**Savon** de Marseille ou lotion acide : **Lactacyd**

-Traitement du partenaire

3-Jaunatres : « gonocoque »

-**Vibramycine** cp 100mg :

1cp en prise unique à renouveler après 02 sem si l'infection est importante Ou

-**Rovamycine** 04 cp 500mg pdt 04j Ou

-**Extencilline** inj pdt 04j -TRT du partenaire.

4-Transparente:

Vaginose bactérienne(Klebsiella,Gardanella)

-**Rovamycine** cp 3M

1cp x 2 /j pdt 10j

Avortement en cours

/// Contractions utérines (C.U) type coliques expulsives
+ Modification du col + saignement abondant.

C.A.T. Hospitalisation, Bilan standard : FNS, Groupage, TP
. On donne :

// Médicaments agissants sur le corps utérin : 1 seul ou en association

-Syntocinon 5-20 UI en perfusion dans 500cc de SGI à raison de 08 gtte /mn(C.I : col fermé)

-Methergin 1-2 cp x 3 /j = 10-20 gttes x 3/j
(C.I :HTA,Cardiopathie,Hypothyroïdie)

//Médicaments agissants sur le col utérin : (1seul mcmt suffit)

-Cytotec cp 200ug : 02 cp en une seul prise pdt 1 heure puis Methergin.

-Atropine amp 1ml = 0.25mg ----- 1 inj en perfusion

NB : Sonde de foley : Déclanchement mécanique.

-----Malade sortante (a l'écho ligne de vacuité visible ou image de rétention < 20mm

-Amoxicilline cp 1g x 03/j pdt 10j

-Ferrosanol gyn gel : 1gel/j (si Hb<7 : 02/g pdt 1 mois puis 1 gel/j pdt 2mois)

***** Si curetage : Cycle artificiel :

.Progynova cp 1mg : 1cp x 02/j pdt 14j puis

.Duphaston cp 10mg : 1cp x 02/j pdt 14j

L'Eclampsie

- Crises convulsives généralisées survenant par accès suivis d'un état comateux.
- les prodromes : -Aggravation de l'HTA, de la protéinurie,
 - Œdèmes, des céphalées (en casque)
 - Somnolence, acouphènes.
 - Dlre épigastrique.



Risques Maternels :

- E**tat de mal convulsif.
- A**sphyxie, Œdème cérébral.
- D**écollement de la rétine.
- CPC** cérébrales : Hgie, Œdèmes.



Risques Fœtaux :

- Souffrance Fœtale
- Mort in-Utéro

C.A.T

- L**ibération des voies aériennes sup et assistance resp.
- T**raitement Anticonvulsivant (**Benzodiazépine**).
- E**xtraction fœtale en urgence dès l'arrêt des crises.
- R**écidives possibles dans les premières 48 h du post-partum ----- TRT Préventif : **Sulfate de Magnésium**.

C.A.T devant une Salpingite

-Hospitalisation

.Augmentin cp 1g x 03/j

.Doxycycline cp 100mg : 1cp x 02/j

.Flagyl cp 500mg : 1cp x03/j pdt 21 jours

—————> On peut remplacer l'**Augmentin** par de la **Vibramycine** et la **Doxycycline** par la Gentamycine ou par l'**Ofloxacin** cp 200mg 1cp x02 /j.

+ une contraception monodosée (qui bloque l'ovulation).

Traumatisme pelvien

-Après examiner la malade et vérifier qu'elle n'est pas en menace : Toucher + Echo.

/// Pas de fracture : juste des douleurs :

-Indocid (ains) 50mg..... 01 Bte 01 supp/j

-Tramadol gel..... 01 Bte 01 gel x 03/j

-Spasfon Supp..... 01 Bte 01 supp x 03/j

-Oméprazol cp..... 01 Bte 01 cp/j

+ Repos ; Position Antalgique (DLG)

Syndrome grippal

-Amoxicilline cp 1g : 1g x 03/j (QSP 10j)

-Doliprane CP 500 mg 1cp x 03/j

-Vitamine C

C.A.T devant un décollement placentaire

-Apprécier la surface du décollement placentaire.

.Progestérone inj 02 Bte 01 inj IM /j
puis 01 inj/3j

.Indocid supp 50mg..... 01 Bte 01 supp le
soir pdt 05 jour

.Dicynone cp 250mg..... 01 Bte 1 cp x 03/j

Le Syndrome d'Hyperstimulation Ovarienne

-Schéma de réhydratation (Alternance SSI – SGI à 5 P 100)

-Lovénox 0.4 UI en S/C /j

-Albumine : 1g/j

-Céfacidal : 1g/6/j

-Solumédrole : 240 mg dans 250 cc de SSI pdt 48h.

Puis 120 mg dans 100 cc de SSI pdt 24h.

Puis 80 mg dans 100 cc de SSI pdt 04h.

C.A.T devant une Bartholinite

-Amoxicilline cp 1g..... QSP 10j 1g x 03/j

-Gentamycine 80mg inj x 02/j Pdt 05j (femme non enceinte)
Pdt 48h (femme enceinte)

-Betadine solution (toilette).

C.A.T devant une suspicion d'une Chorio-amniotite

-Signes d'orientation : .Fièvre post –RPM
.Tachycardie fœtale

Biologie: **-FNS**

-CRP

-La couleur du liquide et sa bactériologie

//// Hospitalisation : Bilan standard : FNS , Groupage , TP,
CRP chaque 48h, Bilan Rénal.

Trithérapie : **-Ampicilline** 1g x 04/j en IVD

-Flagyl 500mg x 03/j

-Gentamycine 80mg/j pdt 05j

+ un **Anti-inflammatoire** + **Antispasmodique**.

Surveillance de la T°, Pouls, TA.

Prélèvement Vaginal avec **ECB** et

Antibiogramme.

C.A.T devant une anamniose

-Dexamethasone inj 0.4mg----- 12mg/sem en IM

Qtt selon l'âge gestationnel. Bte :5 amp

-Amoxicilline 1g x 03/j Pdt 10j

(Pour prévenir la chorio-amniotite)

CRP /48h ----- Si **CRP +** ----- On Déclanche

Syncope avec Hypotension ou DNV(Dystonie neurovégétative)

- Gelphore** amp ----- 01 Bte
- Salbutamol** cp 2mg ----- 01Bte 1cp x 04/j Si suspicion de menace.

Trouble de cycle + Saignement abondant

- Dicynone** inj ----- 01 Bte inj/j en IM
- Orgamétil** cp ----- 01 Bte (NB : œstrogène de synthèse)
- Ferrosanol** gyn gel ----- 01 Bte 1 gel /j

Douleurs pelviennes

- Utrogestan** 100mg----- 01 Bte 1 ovule /j le soir
- Spasfon** supp ----- 01 Bte 1 suppo x 04/j en cas de douleur

NB :

- L'Activité Cardiaque est perçue à partir de la 7^{eme} SA
- Signes de dépassement de terme à l'échographie :
 - . Placenta Calcifier
 - . Liquide Amniotique réduit

Les Antihypertenseur qu'on peut donner à une femme enceinte

I- Les Antihypertenseurs Centraux :

-Aldomet : cp 250mg : 1 cp x3/j (dose minimal)

Si HTA rebelle : 1cp x 4/j sinon 2 cp x 03/j(dose maximal)

C.I : I^{ce} Hepatique

-Catapresson amp (0.15 mg/ml) 1 amp/4h en perfusion

II- Inhibiteur Calciques :

-Loxen : inj (trt des pics) :1cc dans 3cc de SSI en IVD

Ou 3-4cc /h par pousse Seringue électrique (PSE)

Ou gel 50 mg : 1 gel x 2/j (TRT en association avec la dose max d'Aldomet)

III- B.Bloquants cardio-selectif :

NB : les β - β non sélectifs sont contre indiqués.

-Acébutolol (setrol) cp 200 mg..... 1-2cp/j

-Aténolol cp 100 mg..... 1cp/j le matin

-Tenormine cp 100 mg..... 1cp/j le matin

IV-Sulfate de Magnesium : 3-5 amp : 2-8cc/h dans 500cc de SSI en perfusion lente.

V-Vasodilatateur :

-Nepressol : amp 25mg 0.5 mg /min en perfusion

Complications de l'Allaitement

1. Crevasses du mamelon : Les crevasses sont des **fissures cutanées du mamelon et/ou de l'aréole**. Il s'agit de petites déchirures de la peau dues à un mauvais étirement de la zone mamelon-aréole. Ces fissures sont très douloureuses et il peut arriver qu'elles saignent.

Les causes des crevasses sont :

- Une mauvaise position du bébé (le plus fréquent)
- Un mauvais geste de succion
- Un étirement de l'aréole avec un doigt appuyé sur le sein pour dégager le nez du bébé
- Un retrait brutal du sein en fin de tétée

C.A.T

- . **D**ésinfection des lésions 1 fois/j
- . **H**ydratation du mamelon .Oxyde de Zinc/tbe 1ap apres allt
- . **E**ncourager encore l'allaitement (le lait a un effet cicatrisant)

2. Engorgement mammaire : L'engorgement est la congestion des vaisseaux mammaires entraînant un œdème du sein. Il survient fréquemment de façon physiologique vers J3 (troisième jour après l'accouchement) au moment de la « montée de lait », mais il peut également survenir plus tard, si une tétée est « sautée ».

C.A.T :

En prévention :

=> Allaiter bébé à la demande, surtout au moment de « la montée de lait », vers J3 J4 afin de stimuler votre production.

=> Porter un soutien gorge à votre taille qui ne vous serre pas trop, en effet, la compression des canaux peut gêner leurs évacuations et ainsi favoriser un engorgement localisé.

=> Ne pas « sauter » les tétées de nuit (sauf si bébé dort) surtout les premières semaines. En effet, la prolactine est essentiellement sécrétée la nuit.

En traitement :

=> Faire téter en priorité le sein engorgé.

=> Surtout ne pas utiliser de tire lait. En effet cela va vous soulager sur l'instant, mais vous allez stimuler vos seins, qui vont fournir toujours autant de lait.

=> Massez vos seins, afin de les vider sans les stimuler. Ce massage peut être fait sous une douche chaude ou après avoir mis des compresses ou un gant chaud sur vos seins, ce qui le rendra plus facile, et plus agréable.

3. Lymphangite (ou mastite inflammatoire) :

C'est une inflammation des vaisseaux lymphatiques du sein. Elle se manifeste au cours de l'allaitement et peut faire suite à un engorgement des seins.

Traitement

.Le traitement sera forcément antibiotique.

.En attendant, vous pouvez faire des pansements alcoolisés à humidifier en permanence.

La lymphangite guérit en 8 à 10 jours.

.En ce qui concerne l'allaitement cela dépend de l'antibiotique utilisé et de la localisation de la lymphangite et de son risque de passage à l'abcès du sein.

Pour éviter la lymphangite, le mieux est de limiter les risques d'engorgement du sein.

4. Galactophorite (ou mastite infectieuse)

.Arrêt temporaire des tétées jusqu'à guérison.

.ATBpie

5. Abcès du sein :

.Arrêt de l'allaitement.

.Hospitalisation. *PNS*

.TRT chirurgical (incision, lavage, drainage, de l'abcès)

.TRT Médical (**ATB**)

.TRT symptomatique : soins locaux et antalgiques.

C.A.T DEVANT UN FIBROME UTERIN

Le Fibrome utérin: est une affection gynécologique très fréquente qui touche 25 % des femmes de 40 à 50 ans et jusqu'à 50% au-delà. Elle se manifeste svt par des métrorragies.

CAT :

Si Présence de Saignement :

-ORGAMETRIL 02 Cp x 2/j

puis 01 Cp x 2/j le 2ème cycle du 5ème au 25ème jour de cycle

NB : les **C.I** de l' **ORGAMETRIL :**

HTA-Diabète-AVC- Hyperlipidémie

-Si **C.I :-DUPHASTON**

Ou **-SURGESTONE** : 0.25 ----- 02cp/jr

0.5 ----- 01cp/jr

-DICYNONE

01cp x 3/j jusqu' à l'arrêt du saignement

Si Absence de Saignement :

-ORGAMETRIL

1CP x 2 /j

-Si Malade en Préménopause non mariée :

On continue le trt jusqu'à la ménopause

-Si Malade Mariée désirante la Grossesse :

TRT Chirurgical conservateur

-Si non réponse au TRT

TRT Chirurgical radical

C.A.T devant une R.P.M

L'RPM se fait sur une grossesse de moins de 28 semaines d'aménorrhée qui nécessite svt un déclanchement. Risque de chorioamniotite srt avec fièvre.

-Si Grossesse inf à 28 SA : ----- déclanchement

-Amoxicilline Cp 1 g } **CRP** chaque 48h jusqu'à négativité
1cp x 3/jr } des **CRP**
+ écho chaque 24h (AC-LA)

.02 CRP négatives SORTANTE sous - ATB : 01g x 3 /j

-**CRP** chaque semaine

.Si CRP positive on demande une **CRP** avec titrage
valeur :

-Si **CRP** est en augmentation **90----- Déclanchement**

-Si **CRP** est en diminution ----- **Sortante**

+ ATB + CRP chaque semaine

-CEFACIDAL 01g x 3 /j

-Si Grossesse Sup à 28 SA : risque de : Chorioaminiotite

+ Souffrance foétale :

::::: ENTRE 28-35 SA : **-CRP + : AMOXICILLINE** + CTC :

Dexamethazone 12 mg en IM/j Pdt 48h

-CRP - : CEFACIDAL +tocolyse :

05 amp de **Salbutamol** dans 500cc de SG à 5%

+CRP chaque 48h

-Si Grossesse Sup à 35 SA :----- Déclanchement :

Soit : --5 UI de **SYNTO dans 500cc de SG à5% + traine de **Spasfon** chaque 1 /4 h 1 amp en IM chaque 15 min**

-- Déclanchement par cocktail :

- 1 amp de **Spasfon + 1 amp d'**Atropine****

-1 amp de **Primperan + 5UI de **Synto** dans500 cc de SG
+1/2 amp de valium en IV
+1/2 amp de valium en IM**



Relâchement de col

-Si Grossesse Sup à 35 SA + HYPOTROPHIE FŒTAL :

même CAT + temporiser

-Si RPM à Terme : Pas d'hospitalisation avant 24h

-AMOXICILLINE : 01 g x 3/jr

-SPASFON SUPP: 01 supp x 4/jr

puis hospitalisation après 24h + déclanchement :

5 UI **Synto** ;7.5 ;10 + SONDE DE FOLEY si col fermé on dépasse l'orifice ant du col et on gonfle le ballonnet.

NB : *si col fermé*

.1 /2 cp cytotec en intra-cervical ou en intra-rectal

Pour la maturation cervical si présence de saignement relai par synto.

.Puis Synto après maturation

Si col ouvert Synto seulement 5 UI ds 500cc de SG 5%

CAT DEVANT UN KYSTE OVARIEN

1-KYSTE FONCTIONNEL :

C'est un kyste qui évolue avec le follicule ovarien d'où la nécessité de faire un écho le 3ème jr des règles.

NE PAS TRAITER.

2-KYSTE ORGANIQUE :

.kyste inf à 04cm : Pilule + AINS

-----SOIT : OESTROPROGESTATIFS :

Stediril ou, **Diane 35** ou **Minidril**

QSP 03 MOIS + SAPOFEN 600 ou **ANTADYS**

-----SOIT :-PROGESTATIFS :

Duphaston cp à 10 1cp x 2/jr du 16ème au 25ème jr de cycle ou **Utrogestan** 100 1cp x 2 /jr du 16ème au 25ème jr de cycle ou **Lutenyl** 1 cp/jr du 16ème au 25ème jr de cycle **QSP 03 MOIS + AINS**

-Kyste sup à 04cm : Risque de torsion ----- Trt médical + chirurgical

-Kyste persistant :Trt chirurgical

-Rupture de kyste : **Spasfon** +ATB

NB :- Surveillance chaque 03 mois dans tout les cas

-Avant l'âge de 18 ans :- ne pas traiter immaturité hypophysaire -si persistance d'aménorrhée primaire on traite à l'âge de 18 ans

C A T
Menace d'ABRT

A- Début de Gsse ----- < 28 SA

B-

De 0 ----- 8 SA

Spasfon supp 1 x 3 /J

.Contracture utérine positif + Saignement + Echo : sac en place

.En cas de saignement : **Dicynone** 1 cp x 3/J jusqu'à l'arrêt

De 8----- 12 SA

Utrogestan cp (100 et 200)

1 voie orale -----> 2 le soir (voie vaginale)))

200 si menace sévère

Effets secondaire Vertige, Somnolence (Voie orale)

Si hospitalisation 3 ampoules de **Spasfon** en perfusion
+ **Dicynone** inj **IM** 1 amp x 3 /j

De 12-----16 SA

progestérone Inj en **IM**

.Si Douleur seulement 1 inj x 2/j

.Si Douleur + saignement

1ere boite 1 inj/j pendant 3j

2eme boite 1inj/3j pendant 9j

3eme boite 1inj/5j pendant 15j

Saignement : On ajoute

Dicynone

Utrogestan 200 1 ovule/J

De 16 ----- 28 SA

.Salbutamol cp 2mg 1 cp x 4/J

.Indocid supp 50 1 supp/J pdt 5j

.Progestérone inj 1 inj/5j **ou Utrogestan** 200 1 ovule le soir

Si menace sévère .Unipare : col 1 doigt ou + ----- (H_{tion})

.Multipare : col 2 doigt ou + ----- (H_{tion})

+ **Progestérone**

En cas d'Hospitalisation : (forte contracture utérine + modification cervicale, effort physique, Infection)

Salbutamol : 5 amp dans 500cc de SG a 5% **ou**

Sulfate de Magnésium : 4 amp dans 500cc de SG 5% **ou**

Loxen : 3 amp

NB : la Tocolyse dure 48H puis le relai se fait par voie orale 2 heures avant la fin de la perfusion. En utilisant :

.Salbutamol 1 cp x 4/j ou

.Adalat cp 200mg 1cp x 2 /j ou

.Loxen gélules 1 gel x 2/j

B-Plus de 28 SA : M.A.P : même conduite + Corticoïdes pour accélérer la maturation pulmonaire.

Dexametasone : 12mg /j pendant 48h en IM

Amp 4mg Q.S.P (quantité suffisante pour) 48H

12 mg/j donc 03 amp/j en IM

C-Plus de 35 SA : < 85 bip → Tocolyse pdt 48h

> 85bip → Expectative

TRT DE SORTIE :ABRT

.Amoxicilline cp 1g----- QSP 8j

1cp x 3 /jr

.Ferrosanol gyn gell----- 01 Bte

1gel/jr

.Methergin gtte----- 01Bte

20 gttes x 3/jr

.lactacyd ----- 01 flacon

1 toilette x 2/jr

.Gracial « pilule »----- QSP 3Mois

NB : Methergin : Augmente le tonus des fibres musculaire de l'utérus

C.I absolues : cardiopathie

Relatives : varices-HTA-utérus cicatriciel-

IM Levothyrox ,Parlodel

DEPACEMENT DE TERME

-Colpotrophine ovule 1 ov x 3 /jr

-Spasfon supp 1 supp x 4/jr

TRT DE SORTIE :Après cerclage

-Progestérone inj----- 03 Bte

1ere bte : 1 inj/jr en IM

2eme bte : 1 inj /3jr en IM

3eme bte : 1inj/5jr en IM

-Polygynax ovule----- 01 Bte

1 ov/jr

-Lactacyd ----- 01 flacon

1 toilette x 2 /jr

-Gestarelle cp ----- 01 Bte

1 cp /jr

NB :Gestarelle :poly vitamine

HTA et Grossesse

-HTA gravidique ----- HTA sans oedemes

-HTA chronique ----- HTA ATCD HTA

-HTA chronique + éclampsie

Physiopathologie : anomalies (ischémie) du placenta-----
retentissement organique

Cardiaque IDM, Rein diminution du flux 'IRA', placenta
hypoperfusion, souffrance fœtale,

RCIU+HRP,SNC,Foie(cholestase, synd de Hellp) saignement
(hémolyse, CIVD)

Examen complémentaire :

-FNS, PLT, Crea, Bilan hépatique TGO TGP, ionogramme, Glycémie a jeun Hémostase uricémie.

Pr⁽⁻⁾ Totaux Alb. Urée/Crea. Acide Urique. Pr⁽⁻⁾ des 24h

Et profil de la **TA**.

NB : FO et ECG si Pré-eclampsie

CAT

Bilan +Echo (AC, Xce) chaque 48H + prise de tension artérielle + chimie des urines

TRT :

- **Loxen** en bolus 2cc en IV lente >>>20mn>>>2eme bolus

-**Sulfate de magnésium** puis -**Aldomet** 1cp x 3 >>> 2cp x 3 si (-) + **Loxen** gel 1 gel a 8h et a 20h

Hospitalisation:

-**HTA** inaugurale + saignement de pre-eclampsie

-**HTA** chronique malgré une dose de 2cp *3/j on hospitalise sinon on augmente les doses à domicile.

Crise d'**E**clampsie : **Valium** 10mg en IV + **Sulfate de Magnesium** (prevenir la crise)

4 amp /4cc de SG 5%

Si Persistance des crise >>>>>>>> Bloc

Abcès de la paroi abdominale après Hystérectomie

- .Cefacidal** 1g x 4 en perfusion
- .Flagyl** 500 mg x 3 en perfusion
- .Gentamycine** 80mg x 2 en perfusion
- .Perfalgan** 1g x 3 en perfusion

Accouchement Normal

- .Amoxiciline 1g** ----- QSP 10j
1cp x 3/j
- .Fraxiparine** 0.3 ml ----- n° 6 (ou **Lovenox**)
1 inj/j
- .Ferrosanol** gyn ----- 1 Bte
1gel x 2/j
- .Lactacyd** lotion ----- 1 Flc
1 toilette x 2/j
- .Cirazette** pilule ----- QSP 03 mois
1 cp/j (Allaitement)
- .Dermobacter** (si épisiotomie)
1 app x 2/j

Si Césarienne on donne **Cefacet** 1g x 3/j QSP 10j

Fraxiparine N° 08 + **Methergin** gtte 15 gttes x3/j

Si synd infectieux **Doliprane** 500mg x 04/j + **Solumedrol** 40mg 01 inj/j pdt 03j

Varices **Daflon** . Forceps **Ampicilline**. Hémorroïdes **Tetanoreïne**

Grossesse jeune exp : 8-9 SA A.C +^{ve} (menace)

Ordonnance

-**Progesterone**^{inj} ----- (01 Bte

1 Inj en IM /5j

-**Utrogestan** ovule 200 mg ----- (01 bte

1 ovule le soir

-**Riabal** cp ----- (1 Bte

1 cp x 3/j

C.A.T devant un Tble de Cycle

Age osseux = Age chronologique + 2

Cycle 15-21ans

-Hyper-sécrétion d'œstrogène :

- Bouffées de chaleur
- Tension mammaire
- Irritabilités
- Œdèmes des mbres inferieur

-Hyper-sécrétion androgene

- Hirsutisme
- Acné
- Voix rauque

-----**Métrorragies** : progestatif jusqu'à l'arrêt du saignement 3cp/j (1 le matin ;2 le soir) +20j après l'arrêt du sgment .puis 2cp/j du 16^{me} au 25^{me} jour du cycle.(3 mois)
+ Ecoho pelv et endo-vag

-----**Aménorrhées** : progestatif du 16^{me} au 25^{me} j du cycle
2cp/j plus prise en charge psychologique.

-----**Irregularité menstruelle** : *Spanioménorrhée*

Prog du 16^{me} au 25^{me} jour du cycle pdt 6-12 mois

-----**Dysmenorrhée**: *Dires (manque deprog ;malformation de l'ovaire)*

Prog du 16^{me} au 25^{me} jour du cycle(03 mois)

Duphaston 2cp/j

Antalgique

Antispasmodique

Antiprostaglandine (AINS)

Fenamate – Acide propionique

Ordonnance pour la Montée laiteuse

Phytolait gel-----1bte

1gel x 2/j

Tire lait

Bout de sein (en célicone)

Emission des Gaz

-debridat Sirop 1 cas x3/j ou

-Normacol tube

1 app/j

Pour inhiber la montée Laitieuse

-Parlodel inhibe la production de la prolactine

$\frac{1}{2}$ cp le 1 ^{er} jour	}	jusqu'à l'arrêt
$\frac{1}{2}$ cp x 2 le 2 ^{me} jour		
1 cp x 2 le 3 ^{me} jour		

Pour les Dlres Pelviennes et la Toux

-Salbutamol cp 2mg

1cp x 4/j si dlres atroces sinon 1 cp

-Amoxicilline cp 1g

1cp x 2/j

-Soothex sirop 1 cas x 2/j /////si femme diabétique

Toplexil sirop

Les Bilans Normaux

-VS 1^{ère} heure < 10mm

2^{ème} heure < 20 mm

-FNS H^{te} : 31 - 45%

Hb : 11 - 14.5g/dl

GR : 4 - 5.5 10⁶/ml

GB : 4.5 - 11 x 10³/ml

PLq : 150 - 400 x 10³/ml

-CRP < 6 (-)^{ve}

> 6 (+)^{ve}

-Glymie : 0.7 - 1.1g/l

-Urée : 0.15 - 0.50 g/l

-Creat^{mie} : 6 - 14 mg/l

-Ac-Urique : 25 - 70 mg/l

-HDL > 1.50

-TGP(ALT) : 0 - 40 UI/l

-BLB^{tot} : 3.14 - 17 umol/l

-Phos^{ase} ALC^{ne} : 70 - 300 UI/l

-Phosphore : 28 - 45 mg/l

-TIBC : 44.5 - 73.5 umol/l

-Ionogramme : . Na⁺ : 135 - 148 meq/l

. Cl⁻ : 98 - 107 meq/l

. K⁺ : 3.5 - 5.3 meq/l

-Cholestérol : 1.4 - 2.5 g/l

-TGO (ASAT) : 0 - 40 UI/l

-TG^{des} : 0.4 - 1.65 g/l

-BLB^{drct} : 0 - 3.4 umol/l

-Ca⁺ : 85 - 106 mg/l

-Fer^{Serique} : 10.7 - 28.3 umol/l

-Hb^{Gluqué} : 402 - 6.2%

///ACEBUTOLOL

200 mg : comprimé ; boîte de 30

400 mg : comprimé ; boîte de 30

Antiangoreux : bêtabloquant (Acébutolol)

Antiarythmique : groupe II : bêtabloquant : acébutolol

Antihypertenseur : bêtabloquant (Acébutolol)

Ce médicament est un générique de SECTRAL

INDICATIONS

Ce médicament appartient à la famille des bêtabloquants.

Ceux-ci agissent en bloquant l'action de l'adrénaline (et d'autres hormones apparentées) sur de nombreux organes, notamment sur le coeur, les vaisseaux, et plus faiblement sur les bronches. Il est utilisé dans :

- le traitement de l'hypertension artérielle,**
- la prévention des crises d'angine de poitrine,**
- les suites d'infarctus du myocarde,**
- certains troubles du rythme cardiaque.**

CONTRE-INDICATIONS

- formes graves de certaines affections : asthme, bronchite chronique, artérite, phénomène de Raynaud ;**
- insuffisance cardiaque non contrôlée par un traitement spécifique ;**
- bloc auriculoventriculaire grave ;**
- rythme cardiaque inférieur à 50 battements par minute ;**
- phéochromocytome non traité ;**
- hypotension ;**
- antécédent de choc anaphylactique ;**
- en association avec les médicaments contenant de la floctafénine ou du sultopride ;**
- allaitement.**

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas.

Posologie usuelle:

Hypertension artérielle : 1 comprimé à 200 mg matin et soir, ou 1 comprimé à 400 mg le matin.

Suites d'infarctus du myocarde : 1 comprimé à 200 mg, matin et soir.

Angine de poitrine, troubles du rythme cardiaque : 400 à 800 mg par jour

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Le plus fréquemment : douleur d'estomac, nausées, vomissements, fatigue en début de traitement, sensation de mains et de pieds froids, troubles de l'érection, ralentissement important du coeur.

Plus rarement : bloc auriculoventriculaire, baisse excessive de la tension artérielle, phénomène de Raynaud, insuffisance cardiaque, bronchospasme, hypoglycémie, éruption cutanée, aggravation d'un psoriasis.

///Adalate Nifédipine

-10 mg Capsule orange Boîte de 30 et de 90

-LP 20 mg : comprimé à libération prolongée (orangé) ; boîte de 30 et de 60

-BÊTA-ADALATE : gélule (blanc et brun-rouge) ; boîte de 28 : contient deux substances : l'*aténolol*, un bêtabloquant qui bloque l'action de l'adrénaline (et d'autres hormones apparentées) sur de nombreux organes et notamment sur le coeur, les vaisseaux et plus faiblement sur les bronches ; la *nifédipine*, un vasodilatateur de la famille des inhibiteurs calciques. Son action renforce celle de l'*aténolol*.

vasodilatateur qui appartient à la famille des inhibiteurs calciques. Il est utilisé dans :

Le traitement de l'angor de Prinzmetal ;

Le traitement préventif des crises d'angine de poitrine, en association avec un bêtabloquant ;

Le traitement symptomatique des phénomènes de Raynaud.

Sa posologie

Voie orale : La capsule est à avaler sans croquer avec un peu de liquide.

Angor.Prinzmetal 1 capsule 4 / j dont une le soir au coucher.

l'angor stable 1 capsule 3 /j en association à un bêta-bloquant administré à posologie efficace.

La posologie maximale est de 60 mg/j.

Phénomènes de Raynaud : 1 capsule 3 /j.

///ANTADYS

Comment ça marche

ANTI-INFLAMMATOIRE NON STERODIEN.

- Le flurbiprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l'acide arylcarboxylique, appartenant au groupe des propioniques. Il possède les propriétés suivantes :

- . activité anti-inflammatoire,*
- . activité antalgique,*
- . activité antipyrétique.*

. inhibition de courte durée des fonctions plaquettaires.

- L'ensemble de ces propriétés est lié à une inhibition de la synthèse des prostaglandines.

Sa posologie

- Affections rhumatismales :

. traitement d'attaque : 1 comprimé, 3 fois par jour, soit 300 mg par jour.

. traitement d'entretien : 1 comprimé, 1 à 2 fois par jour, soit 100 à 200 mg par jour.

- Dysménorrhées : 1 comprimé 2 ou 3 fois par jour, soit 200 à 300 mg par jour dès le début des douleurs et jusqu'à disparition des symptômes.

- Les comprimés sont à avaler tels quels, sans être croqués, avec un verre d'eau, de préférence au cours des repas.

///ATÉNOLOL

50 mg : comprimé ; boîte de 28; boîte de 84.

100 mg : comprimé sécable ; boîte de 28 ; boîte de 84

Indication c-indication effets indésirables clse thérapeutique même chose que L'ACEBUTOLOL.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce médicament est pris indifféremment au cours ou en dehors des repas.

Posologie usuelle:

50 mg à 100 mg par jour, selon les cas.

Dans l'HTA, la dose quotidienne est prise de préférence le matin

///ATROPINE SULFATE

Classe thérapeutique **Antalgiques**

0,25 mg/1 ml, 0,50 mg/1 ml et 1 mg/1 ml : Ampoules de 1 ml, boîtes de 10.

INDICATION

-  **Préanesthésie** : protection des manifestations vagales (bradycardie à l'induction).
-  **Bloc auriculoventriculaire ou atrioventriculaire.**
-  **Dans l'infarctus** : prévention et traitement des blocs auriculoventriculaires et des bradycardies sinusales.
-  **Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.**
-  **Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques et douloureuses des voies urinaires.**
-  **Solution injectable à 1 mg/ml** : antidote spécifique dans les intoxications aiguës par les anticholinestérasiqes (insecticides organo-phosphorés et carbamates) ou par les médicaments parasymphomimétiques ou cholinomimétiques.

POSOLOGIE

Voie sous-cutanée, intraveineuse lente ou intramusculaire selon l'indication.

La spécialité doit être administrée sous contrôle médical.

- Antispasmodique (voie SC) : . chez l'adulte : 0,25 à 1 mg toutes les 6 heures, posologie maximale : 2 mg/24 h ;

. chez l'enfant :

* au-dessus de 6 ans : 0,50 mg en dose unique,

* entre 2 et 6 ans : 0,25 mg en dose unique.

- Médication pré-anesthésique (voie SC) :

. chez l'adulte : 1 mg ;

- . chez l'enfant (30 mois à 15 ans) : 0,1 mg à 0,5 mg ;
- . chez le nourrisson (1 à 30 mois) : 0,1 mg à 0,3 mg.
- En cardiologie (voie IV lente) : chez l'adulte : 0,5 à 1 mg.

CONTRE-INDICATIONS

Absolute(s) :

-  Hypersensibilité aux atropiniques
-  Hypersensibilité à l'un des composants
-  Glaucome à angle étroit
-  Rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques,
-  Allaitement

Relative(s) :

-  Grossesse

EFFETS INDESIRABLES

-  Hyposialie
-  Hyperviscosité des sécrétions bronchiques
-  Hyposécrétion lacrymale
-  Trouble de l'accommodation
-  Tachycardie
-  Palpitation
-  Constipation
-  Rétention urinaire
-  Agitation
-  Irritabilité : Sujet âgé.
-  Confusion mentale : sujet âgé

AUGMENTIN

- Comprimé pelliculé adulte à 500 mg/62,5 mg : Boîtes de 16 et de 24
- Poudre pour suspension buvable adulte à 1 g/125 mg : Sachets-dose, boîtes de 8 et de 12.
- Poudre pour susp buvable enfant à 500 mg/62,5 mg : Sachets-dose, bte de 12.

- Poudre pour suspension buvable enfant à 100 mg/12,5 mg par ml : Flacon correspondant à 60 ml de suspension buvable reconstituée, soit 224 doses-graduation (avec seringue pour administration orale de 8 ml graduée en kg).
 - Poudre pour suspension buvable nourrisson à 100 mg/12,5 mg par ml* : Flacon correspondant à 30 ml de suspension buvable reconstituée, soit 112 doses-graduation (avec seringue pour administration orale de 4 ml graduée en kg).
 - Poudre pour suspension buvable nourrisson à 250 mg/31,25 mg* : Sachets-dose, boîte de 12.
- rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1.

INDICATIONS

Augmentin adulte :

- ✓ Otites moyennes aiguës de l'adulte.
- ✓ Sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.
- ✓ Surinfections de bronchites aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique, tabagique, âgé de plus de 65 ans, en cas de risque évolutif ou en seconde intention.
- ✓ Exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.
- ✓ Pneumopathies aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique, tabagique, âgé de plus de 65 ans ou présentant des troubles de la déglutition.
- ✓ Cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.
- ✓ Infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les .
- ✓ Parodontites.
- ✓ Infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites.
- ✓ Traitement de relais de la voie injectable.

Augmentin Enfant :

- ✓ Otites moyennes aiguës du jeune enfant, otites récidivantes.
- ✓ Sinusites.
- ✓ Infections respiratoires basses de l'enfant de 30 mois à 5 ans.
- ✓ Surinfections de bronchopneumopathies chroniques.

- ✓ Infections urinaires récidivantes ou compliquées, à l'exclusion des prostatites.
- ✓ Infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites, parodontites.
- ✓ Augmentin Nourrisson (moins de 30 mois) :
- ✓ Otites moyennes aiguës.
- ✓ Infections respiratoires basses.
- ✓ Infections urinaires.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Posologies exprimées en amoxicilline.

Augmentin adulte

(cp à 500 mg/62,5 mg et pdre p susp buv à 1 g/125 mg)

Adulte (poids $\geq$ 40 kg) :

2 g/jour en 2 prises dans les indications suivantes :

sinusites maxillaires aiguës ;

surinfections de bronchites aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique, tabagique, âgé de plus de 65 ans, en cas de risque évolutif ou en seconde intention ;

*exacerbations de bronchopneumopathies chroniques ;
parodontites.*

3 g/jour en 3 prises dans les indications suivantes :

autres formes de sinusites ;

otites moyennes aiguës ;

cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et

pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles ;

infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae ;

infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites ;

*pneumopathies aiguës du patient à risque, notamment éthylique chronique, tabagique, âgé de plus de 65 ans ou présentant des troubles de la déglutition ;
traitement de relais de la voie injectable.*

Augmentin enfant

*(pdre p susp buv à 500 mg/62,5 mg et à 100 mg/12,5 mg) :
80 mg/kg/jour en 3 prises, sans dépasser la posologie de 3g/ jour*

Augmentin nourrisson

(pdre p susp buv à 250 mg/31,25 mg et à 100 mg/12,5 mg) :

80 mg/kg/jour en 3 prises.

Les 3 prises sont recommandées afin d'obtenir des concentrations sériques suffisantes au cours du nycthémère.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

Allergie aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines, céphalosporines)

Allergie à l'un des constituants du médicament.

Antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline-acide clavulanique.

Poudre pour suspension buvable (tous dosages) : phénylcétonurie, en raison de la présence d'aspartam (E 951).

Relatives : Méthotrexate

///AZANTAC

Comprimé pelliculé à 150 mg (blanc) : Bte de 30, sous plaquette thermoformée.

Comprimé pelliculé à 300 mg (blanc) : Bte de 14, sous plaquette thermoformée.

Comprimé effervescent à 75 mg (blanc à jaune pâle) : Btes de 14 et de 28, sous film thermosoudé.

Comprimé effervescent à 150 mg (blanc à jaune pâle) : Boîte de 30, en tube.

Comprimé effervescent à 300 mg (blanc à jaune pâle) : Boîte de 14, en tube

Solution injectable IM et IV à 50 mg/2 ml : Ampoules de 2 ml, boîte de 5

Ses indications

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale (après preuve endoscopique de la lésion et de l'infection).*
- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif.*
- Oesophagite par reflux gastro-oesophagien.*
- Syndrome de Zollinger-Ellison.*

Comment ça marche

ANTAGONISTE DES RECEPTEURS H2.

- La ranitidine est un antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine.
- La ranitidine inhibe la sécrétion d'acide gastrique provoquée non seulement par l'histamine, mais également par la pentagastrine, l'insuline, la caféine ou par les aliments.
- La ranitidine n'altère pas la production de mucus, n'affecte pas la sécrétion pancréatique et semble sans effet sur le sphincter inférieur de l'oesophage.
- Activité anti-acide supportée par le couple effervescent "citrate/bicarbonate" :
 - . la capacité anti-acide maximale théorique pour 1 comprimé de 300 mg est de 71,2 mmol d'ions H⁺,
 - . le pouvoir neutralisant est d'environ 95-96% de l'activité anti-acide totale, le pouvoir tampon est d'environ 4-5%.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien : 1 comprimé effervescent à 75 mg, au moment des brûlures et/ou des régurgitations, avec un maximum de 3 prises par jour et sur une période n'excédant pas 2 semaines.

Éradication de *Helicobacter pylori* en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale : Schémas posologiques recommandés (comprimés pelliculés et effervescent à 300 mg) : 300 mg de ranitidine matin et soir associés pendant 14 jours à :
Soit 1 g d'Amoxi matin et soir et 500 mg de clarithromycine matin et soir ;
Soit 500 mg de clarithromycine matin et soir associés à, soit 500 mg de métronidazole ou de tinidazole matin et soir, soit 1000 mg de tétracycline matin et soir ;

Soit, en alternative aux schémas précédents, 1 g d'amoxicilline matin et soir et 500 mg de métronidazole ou de tinidazole matin et soir.

Cette trithérapie sera suivie par 300 mg de ranitidine par jour pendant 2 semaines supplémentaires en cas d'ulcère duodénal évolutif ou 2 à 4 semaines supplémentaires en cas d'ulcère gastrique évolutif.

Ulçère duodénal évolutif : 1 comprimé de ranitidine 300 mg (ou 2 comprimés de ranitidine 150 mg) le soir, pendant 4 semaines.

Ulçère gastrique évolutif : 1 comprimé de ranitidine 300 mg (ou 2 comprimés de ranitidine 150 mg) le soir, pendant 4 à 6 semaines.

OEsophagite : 1 comprimé de ranitidine 300 mg (ou 2 comprimés de ranitidine 150 mg) le soir, pendant 4 semaines avec une éventuelle seconde période de 4 semaines à la même posologie en fonction des résultats endoscopiques.

Traitement d'entretien de l'ulcère duodéal : 1 comprimé de ranitidine 150 mg par jour, le soir.

Syndrome de Zollinger-Ellison : La dose initiale recommandée est de 600 mg par jour. La dose doit être ajustée individuellement, si nécessaire, jusqu'à 1200 mg/jour, et le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement.

En cas d'insuffisance rénale : Réduire la posologie* en fonction de la créatininémie, selon le schéma suivant :

créatininémie de 25 à 60 mg/l (220 à 530 μ mol/l) : 150 mg toutes les 24 heures,

créatininémie supérieure à 60 mg/l (530 μ mol/l) : 150 mg toutes les 48 heures ou 75 mg toutes les 24 heures

Benzodiazépines

DIAZEPAM RENAUDIN 10 mg/2 ml sol in

Solution injectable à 10 mg/2 ml : Ampoules de 2 ml, boîte de 6

INDICATIONS

❖ Urgences neuro-psychiatriques

- traitement d'urgence de l'état de mal épileptique de l'adulte et de l'enfant,
- crise d'angoisse paroxystique,
- crise d'agitation,
- delirium tremens.

❖ Pédiatrie

- traitement d'urgence par voie rectale des crises convulsives du nourrisson et de l'enfant. Anesthésie
- prémédication à l'endoscopie,
- induction et potentialisation de l'anesthésie.

❖ Autre indication

- tétanos.

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

Dose : La posologie sera essentiellement dépendante de la situation clinique. Chez l'adulte, elle varie de 0,1 à 0,2 mg/kg par injection. On peut d'emblée administrer 1 à 2 ampoules par voie IM ou IV lente. Cette dose pourra être renouvelée jusqu'à 4 fois par 24 heures, voire davantage en milieu hospitalier.

-----Injection intra-rectale dans le traitement de la crise convulsive du nourrisson et de l'enfant :

- La solution injectable est utilisée à la dose de 0,5 mg/kg de poids corporel (soit 0,1 ml de solution/kg), sans dépasser 10 mg.

- La quantité voulue est prélevée à l'aide d'une seringue et injectée dans le rectum à l'aide d'une canule adaptable à la seringue. -----

Traitement d'urgence de l'état de mal épileptique du nourrisson et de l'enfant :

- nourrisson : 0,5 mg/kg

- enfant : 0,2 à 0,3 mg/kg Administration par voie IV lente. L'injection pourra être répétée 10 à 20 minutes après.

-Chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique : Il est recommandé de diminuer la posologie, de moitié par exemple. Etat de mal convulsif chez l'adulte : 2 mg/mn en perfusion intraveineuse rapide jusqu'à 20 mg puis perfusion lente avec 100 mg dans 500 ml de solution glucosée, à raison de 40 ml/heure. Voies d'administration Voie intramusculaire ou intraveineuse lente ou perfusion ou voie intra-rectale

. En raison du risque d'apnée en cas d'injection intraveineuse rapide, l'injection intraveineuse doit être lente et faite dans une grosse veine Ce risque d'apnée existe aussi pour la voie intra-rectale chez le nourrisson et l'enfant

. Il est nécessaire de disposer d'un matériel de réanimation respiratoire

. Les injections intramusculaires doivent être profondes. Elles ne sont pas adaptées au traitement des crises ou de l'état de mal convulsif. La voie intramusculaire est déconseillée chez l'enfant

. Durée Le traitement doit être aussi bref que possible

. En cas de relais par la voie orale, l'indication sera réévaluée régulièrement.

CONTRE-INDICATIONS

- *Hypersensibilité aux benzodiazépines*
- *Hypersensibilité à l'un des composants*

- *Insuffisance respiratoire sévère*
- *Syndrome d'apnée du sommeil*
- *Insuffisance hépatique sévère*
- *Myasthénie*

EFFETS INDESIRABLES

Apnée - Douleur au point d'injection - Phlébite - Hépatopathie

Hypersensibilité - Ictère

Nouveau-né: Rectite - Amnésie antérograde - Trouble du comportement

Altération de la conscience - Irritabilité - Agressivité - Agitation

Dépendance physique - Dépendance psychique - Syndrome de sevrage -

Phénomène de rebond - Sensation de vertige - Céphalée

Ataxie - Confusion mentale - Trouble de la vigilance - Somnolence

Insomnie - Cauchemar - Nervosité - Trouble de la libido - Eruption cutanée -

Hypotonie musculaire - Asthénie - Diplopie - Transaminases (augmentation) (Très rare) Phosphatases alcalines (augmentation) (Très rare)

CATAPRESSAN

Comprimé sécable à 0,15 mg (blanc) : Bte de 30, sous plaquettes thermoformées

Solution injectable à 0,15 mg/ml : Ampoules de 1 ml, boîte de 10

INDICATIONS

Hypertension artérielle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

La posologie moyenne est de 1 à 4 comprimés par jour.

La dose quotidienne doit être répartie en deux prises. En pratique, le traitement peut commencer par un comprimé le soir au coucher, l'augmentation posologique se faisant progressivement selon les résultats obtenus et en ajoutant une prise le matin.

La stabilisation tensionnelle est obtenue généralement en 2 à 3 semaines.

La dose d'entretien se situe, selon le cas, entre 1 et 4 comprimés par jour et peut sans danger atteindre 6 à 7 comprimés. Cette action ne s'épuise pas avec le temps.

Catapressan peut être associé à toute autre médication antihypertensive, en particulier aux diurétiques.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients du médicament.

Bradyarythmie sévère due à une maladie du noeud sinusal ou à un bloc auriculoventriculaire de deuxième ou troisième degré.

État dépressif.

Sultopride.

///CÉFACET

PRÉSENTATIONS

CÉFACET Gé 500 mg : comprimé sécable (rond ; blanc) ; boîte de 10. CÉFACET Gé 1 g : comprimé sécable (oblong ; blanc) ; boîte de 6.

INDICATIONS

Cet antibiotique appartient à la famille des céphalosporines de 1^{re} génération (Céfalexine), antibiotiques proches des pénicillines, qui sont actives sur un plus grand nombre de germes que la pénicilline simple. Il est utilisé dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment des poumons, des bronches, du nez, de la gorge ou des oreilles, de l'appareil urinaire.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux céphalosporines. Votre médecin est seul juge pour prescrire ce médicament en cas d'allergie aux pénicillines

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les repas ne modifient pas l'absorption du médicament qui peut donc être pris à n'importe quel moment de la journée.

Posologie usuelle:

Adulte : 2 g par jour, répartis en 2 ou 3 prises.

Enfant : 25 à 50 mg par kg et par jour, répartis en 2 ou 3 prises ; soit, par exemple, pour un enfant de 20 kg : ½ comprimé à 500 mg, matin, midi et soir.

///CEFACIDAL

Principes actifs Céfazoline

1 g Lyophilisat et solution pour usage parentéral (IV) Nécessaire de 1 Flacon de lyophilisat + ampoule de solvant de 5 ml

Comment ça marche

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS de la famille des bêtalactamines du groupe des céphalosporines injectables de 1ère génération.

Ses indications

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis ci-dessous comme sensibles, notamment dans leurs manifestations :

- bronchopulmonaires, - ORL et stomatologiques,
- septicémiques, - endocarditiques,
- génitales et urinaires, - cutanées,
- séreuses, - osseuses et articulaires.

En raison de la faible diffusion de la céfazoline dans le liquide céphalorachidien, cet antibiotique n'est pas indiqué dans le trait des méningites même à germes sensibles.

Posologie usuelle

- Adulte : 0,50 g à 1 g toutes les 8 à 12 heures.
 - Enfant et nourrisson de plus de 30 mois (IM) : 25 à 50 mg/kg et par 24 heures.
- Cette posologie peut être augmentée en fonction de la sévérité de l'infection.*

ESPECES SENSIBLES

- **Aérobies à Gram positif :** *Staphylococcus méti-S. Streptococcus. Streptococcus pneumoniae (30-70%).*
- **Aérobies à Gram négatif :** *Branhamella catarrhalis.. Citrobacter koseri (0-20%). Escherichia coli (20-30%). Haemophilus influenzae. Klebsiella(0-30%).Neisseria gonorrhoeae. Proteus mirabilis(10-20%).*
- **Anaérobies :** *Clostridium perfringens (10-20%).. Fusobacterium. Peptostreptococcus. Prevotella(30-70%). Propionibacterium acnes. Veillonella.*

///Cefizox

Ceftizoxime cephalosporine de 3^{ème} G 1g IM et IV

///COLPOTROPHINE

Capsule vaginale : Boîte de 20, sous plaquettes thermoformées de 10.

Crème à 1 % : Tube operculé de 30 g

Ses indications

Troubles trophiques vulvo-vaginaux.

Comment ça marche

OESTROGENES PAR VOIE LOCALE.

Le promestriène exerce des effets estrogéniques locaux au niveau des muqueuses du tractus génital féminin inférieur, dont il restaure la trophicité.

Après application vaginale, il n'a jamais pu être décelé d'effet hormonal systémique, notamment sur les organes estrogéno-sensibles situés à distance du vagin.

Sa posologie

-une capsule par jour, par voie vaginale par cures de 20 jours.

La posologie doit être adaptée en fonction de l'amélioration obtenue.Des cures d'entretien peuvent être nécessaires.

- Crème : Pendant la première semaine de traitement, 1 application vulvaire par jour, en couche mince, suivie d'un léger massage. Puis, jusqu'à régression des symptômes (en moyenne au bout de 3 semaines) : une application tous les 2 jours

///DAFLON

PRÉSENTATIONS)

DAFLON 375 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 30.

DAFLON 500 mg : comprimé (saumon) ; boîte de 30.

DAFLON 500 mg : comprimé (saumon) ; boîte de 60.

INDICATIONS

C'est un veinotonique et un protecteur vasculaire. Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires.

- Amélioration des symptômes en rapport avec l'insuffisance veino-lymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus).*
- Utilisé dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.*
- des petites hémorragies sous-cutanées se traduisant par des taches rouges ou violacées ;*
- Utilisé dans le traitement symptomatique des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.*
- Utilisé dans les métrorragies induites par le port de dispositif intra-utérin, après bilan étiologique.*
- Utilisé dans les baisses d'acuité visuelle et les troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire.*

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

Posologie usuelle :

4 comprimés par jour, soit 2 comprimés à midi et 2 comprimés le soir, au moment des repas.

Crise hémorroïdaire aiguë : 8 à 12 comprimés par jour.

ATTENTION

Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de phlébite chez les malades alités ou plâtrés. Le traitement de l'insuffisance veineuse repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention. Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

CONSEILS

Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et lymphatique. La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

CONTRE-INDICATIONS

Absolue(s) :

- *Intolérance génétique au galactose*
- *Déficit en lactase*
- *Malabsorption du glucose et du galactose,*
- *Intolérance au fructose*
- *Sucrase-isomaltase,*

MISES EN GARDE et PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Hémorroïdaire, crise** *Crise hémorroïdaire* : L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales. Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu.
- **Traitement à réévaluer en cas de persistance ou d'aggravation des symptômes ou de la pathologie** *Crise hémorroïdaire* : Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu.
- **Administer pendant le repas**

Impatiences Sensations pénibles localisées dans les jambes. Elles se manifestent, généralement lors du coucher, par un sentiment d'inconfort, un besoin irrépressible de bouger les jambes.

Insuffisance veineuse Incapacité des veines des jambes à faire remonter le sang vers le cœur.

veinotonique Désigne un médicament qui a la propriété d'augmenter le tonus de la paroi.

DÉBRIDAT® trimébutin

Comprimé pelliculé à 200 mg (blanc) : Boîte de 30,

Comprimé pelliculé à 100 mg (blanc) : Bte de 30,

Granulés pour suspension buvable : Flacon de 250 ml contenant 152,5 g de granulés, avec godet gradué à 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml et 15 ml.

Sachets, boîte de 30. Solution injectable (IM ou IV) à 50 mg/5 ml : Ampoules de 5 ml, boîte de 25.

Granulés pour suspension buvable à 4,8 mg/ml : Flacon de 125 ml de suspension reconstituée avec mesurette graduée en kg de poids corporel

Antispasmodique musculotrope. Les effets de la trimébutine s'exercent au niveau du tube digestif sur la motricité intestinale

INDICATIONS

Comprimés, suspension buvable :

Traitement symptomatique :

**des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires ;
des douleurs, des troubles du transit et de l'inconfort intestinal liés aux troubles fonctionnels intestinaux.**

Solution injectable :

Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.

Traitement d'appoint de l'iléus paralytique postopératoire et en préparation des examens radiologiques et endoscopiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION Posologie :

Voie orale :

Adulte :

-Comprimés à 100 mg et 200 mg : Réservé à l'adulte.

La posologie usuelle est de 300 mg par jour, soit 1 comprimé à 100 mg x 3 /j

Exceptionnellement, la posologie peut être augmentée jusqu'à 600 mg par jour, soit 1 comprimé à 200 mg 3 fois par jour, ou 6 comprimés à 100 mg par jour.

Le traitement par le comprimé à 200 mg doit être de courte durée.

-Granulés pour suspension buvable : La posologie est de 1 graduation du godet doseur de 15 ml 3 fois par jour, ou 1 sachet 3 fois par jour.

Exceptionnellement, la posologie peut être augmentée jusqu'à 6 graduations du godet doseur de 15 ml par jour, ou 6 sachets par jour.

Enfant :

Granulés pour suspension buvable :

Flacon : Chez l'enfant de moins de 5 ans, il est conseillé d'utiliser de préférence Débridat Enfant et Nourrisson 4,8 mg/ml, granulés pour suspension buvable en

flacon, mieux adapté à cette catégorie d'âge. Toutefois, les doses usuelles chez l'enfant sont :

jusqu'à 6 mois : 1 graduation du godet doseur de 2,5 ml, 2 à 3 fois par jour ;

de 6 mois à 1 an : 1 graduation du godet doseur de 5 ml, 2 fois par jour ;

de 1 à 5 ans : 1 graduation du godet doseur de 5 ml, 3 fois par jour ;

au-dessus de 5 ans : 1 graduation du godet doseur de 10 ml, 3 fois par jour ;

soit environ 1 graduation du godet doseur de 5 ml par 5 kg de poids et par jour.

Sachet : Chez l'enfant au-dessus de 5 ans : la posologie usuelle est de 1 sachet 2 fois par jour. La forme sachet ne convient pas à l'enfant de moins de 5 ans.

Voie injectable :

Une injection IM ou IV d'une ampoule durant la phase aiguë.

///DERMOBACTER

Solution pour application cutanée : Flacons de 125 ml et de 300 ml

Ses indications

Ce médicament contient des antiseptiques locaux . Il est utilisé pour nettoyer la peau et les muqueuses et pour assurer l'antiseptie des lésions infectées ou exposées à un risque d'infection

Comment ça marche

ANTISEPTIQUE.(D : dermatologie).

Association de chlorure de benzalkonium, ammonium quaternaire et de digluconate de chlorhexidine, antiseptique de la famille des biguanides.

Antiseptique bactéricide à large spectre, actif in vitro sur les germes Gram+, Gram-, ainsi que sur Candida Albicans.

Activité rapide à partir d'un temps de contact de 1 minute.

La perte d'activité en présence de protéines et d'exsudat est faible.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

allergie aux ammoniums quaternaires,

en application dans les yeux ou dans le conduit auditif (risque de toxicité en cas de perforation du tympan),

pour la désinfection du matériel médico-chirurgical

ATTENTION

Évitez l'usage prolongé de ce médicament, notamment chez l'enfant, sur les muqueuses et sur des surfaces étendues ou profondément lésées, sans l'avis de votre médecin : risque de passage du médicament dans le sang. Cet antiseptique ne convient pas pour la désinfection des ciseaux, rasoirs et autres objets potentiellement contaminants. De même, il ne doit pas être utilisé pour désinfecter la peau avant une piqûre.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution s'emploie pure sur la peau et diluée au 1/10 sur les muqueuses. L'utilisation de la solution (pure ou diluée) doit toujours être suivie d'un rinçage à l'eau.

Posologie usuelle:

1 ou 2 applications par jour

///Dexaméthasone

Anti-inflammatoire stéroïdien :corticoïde à action immédiate.

DEXAMETHASONE MYLAN 4 mg/1 ml Solution injectable Boîte de 20 Ampoules de 1 ml.

Indications

USAGE SYSTEMIQUE

- *celles de la corticothérapie générale per os lorsque la voie parentérale est nécessaire en cas d'impossibilité de la voie orale (vomissements, aspiration gastrique, troubles de la conscience);*
- *les affections nécessitant un effet thérapeutique rapide:*

allergiques:

- o *oedème de Quincke sévère en complément des antihistaminiques,*
- o *choc anaphylactique en complément de l'adrénaline.*

infectieuses:

- o *fièvre typhoïde sévère, en particulier avec confusion mentale, choc, coma,*
- o *laryngite striduleuse (laryngite sous-glottique) chez l'enfant.*

neurologiques:

- o *oedème cérébral (tumeurs, abcès à toxoplasme?)*

ORL:

- o *dyspnée laryngée*

USAGE LOCAL

Ce sont celles de la corticothérapie locale, lorsque l'affection justifie une forte concentration locale. Toute prescription d'injection locale doit faire la part du danger infectieux notamment du risque de favoriser une prolifération bactérienne.

Dermatologiques:

cicatrices chéloïdes

Rhumatologiques:

- *injections péri-articulaires: tendinites, bursites*
- *injections des parties molles: talalgies, syndrome du canal carpien, maladie de Dupuytren*

///DIANE 35 microgrammes

Comment ça marche

ANTI ANDROGENES et ESTROGENES

Association oestro-antiandrogénique, faiblement dosée en estrogène, Diane 35 possède les propriétés des deux substances :

--l'effet spécifique antiandrogénique de l'acétate de cyprotérone, par inhibition compétitive de la liaison de la 5- α dihydrotestostérone au récepteur cytosolique des cellules cibles, qui freine la production et l'excrétion de sébum, la croissance et le développement du poil.

--Dérivé de la 17- α - hydroxyprogesterone, il a une action progestative. Son action antigonadotrope est additive de celle de l'éthinylestradiol. L'acétate de cyprotérone ne possède pas d'action oestrogénique mais un effet antioestrogène, ni d'action nocive sur la fonction du cortex surrénalien.

Sa posologie

///DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé, en traitement initial doit être initié de la façon suivante :

1er cycle : ingestion quotidienne régulière d'un comprimé en commençant le premier jour du cycle pendant 21 jours.

Cycles suivants : après une pause thérapeutique de 7 jours, reprendre la plaquette suivante pendant 21 jours.

Le traitement devra être poursuivi plusieurs mois, les premiers signes d'amélioration clinique se manifestent au bout de 3 ou 4 mois, parfois plus.

///DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé : en relais d'un contraceptif estroprogestatif oral, doit être initié de la façon suivante :

Prendre le 1er comprimé de préférence le jour qui suit la prise du dernier comprimé actif du contraceptif estroprogestatif oral, ou au plus tard le jour qui suit la période habituelle d'arrêt des comprimés, ou le jour suivant la prise du dernier comprimé placebo du contraceptif estroprogestatif oral.

///DICYNONE étamsylate

protecteur vasculaire et un antihémorragique

FORMES et PRÉSENTATIONS

Cprimé (blanc) à 500 mg et 250mg : Bte de 20, sous plaquettes thermoformées.

Sol inj à 250 mg/2 ml : Ampoules de 2 ml, boîte de 6.

INDICATIONS

Comprimé à 500 mg :

-Utilisé dans les manifestations fonctionnelles de l'insuf^{ce} veinolymphatique (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus).

-Utilisé dans le traitement symptomatique des troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.

-Traitement d'appoint des ménométrorragies après bilan étiologique.

-Utilisé dans les baisses d'acuité et troubles du champ visuel présumés d'origine vasculaire.

Solution injectable à 250 mg/2 ml :

En médecine Proposé dans le traitement des :

saignements par fragilité capillaire,

ménorragies sans causes organiques décelables.

En chirurgie générale ou spécialisée (ORL, ophtalmologie, gynécologie) Proposé pour diminuer les pertes sanguines au cours des interventions chirurgicales, en particulier hrragies en nappe, chez les malades sous anticoagulants.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Cp^{rimé} à 500 mg : 3 comprimés par jour.

Solution injectable à 250 mg/2 ml :

Adulte :

En urgence : 2 à 3 ampoules, 3 fois par jour, en IV ou IM.

En préopératoire : 1 h avant l'intervention, 2 amp IV ou IM.

En peropératoire : à la demande.

En postopératoire : 1 amp IV ou IM, 2 fois par jour.

Nourrisson et enfant :

Même schéma thérapeutique que chez l'adulte en réduisant la posologie de moitié.

NB : la solution injectable peut être utilisée :

par voie orale : diluée dans un demi-verre d'eau,

localement : en tamponnements.

CONTRE-INDICATIONS

Absolues :

Hypersensibilité à l'étamsylate et/ou à l'un des autres composants.

Comprimé : hypersensibilité ou intolérance au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten), notamment chez les personnes atteintes de maladie coeliaque.

Relatives : *En cas d'allaitement*

EFFETS INDÉSIRABLES

Possibilité de fièvre, de céphalées, d'éruptions cutanées et de troubles digestifs à type de nausées, vomissements ou diarrhée.

En raison de la présence de sulfites, risque de réactions allergiques, y compris réactions anaphylactiques, allant du rash au choc anaphylactique, et bronchospasmes .

Doxycycline

100 mg : comprimé ; boîte de 5 ; 15 ; 30

INDICATIONS

- brucellose, - pasteurelloses, - infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae,

- infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes rickettsioses , - Coxiella burnetii (fièvre Q), - gonococcie, - infections ORL et broncho-pulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës des bronchites chroniques,
- tréponèmes (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bêta-lactamines), - spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), - choléra, - acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes.
- Situations particulières : Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

POSOLOGIE :

--- Adultes :

- sujet de poids > 60 kg : 200 mg par jour en une prise,
- sujet de poids < 60 kg : 200 mg le premier jour, 100 mg les jours suivants en une prise.

Cas particuliers : - Gonococcies aiguës :

. adultes de sexe masculin : 300 mg le 1er jour (en deux prises) suivis de 200 mg par jour pendant 2 à 4 jours, ou un traitement minute de 500 mg ou de 2 doses de 300 mg administrées à 1 heure d'intervalle.

. adultes de sexe féminin : 200 mg par jour.

- Syphilis primaire et secondaire :

300 mg par jour en trois prises pendant au moins 10 jours.

- Urétrite non compliquée, endocervicite, rectite dues à

Chlamydia trachomatis :

200 mg par jour pendant au moins 10 jours.

- Acné : 100 mg/jour pendant au moins 3 mois. Dans certains cas, un traitement à demi-dose peut être utilisé.

Situations particulières :

Maladie du charbon : traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif des personnes symptomatiques pouvant recevoir un traitement per os, soit d'emblée soit en relais d'un traitement parentéral : 200 mg par jour en 2

prises. La durée du traitement est de 8 semaines lorsque l'exposition au charbon est avérée.

--- **Enfants de plus de 8 ans** : 4 mg/kg/jour.

- Situations particulières : Maladie du charbon : traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif des personnes symptomatiques pouvant recevoir un traitement per os, soit d'emblée, soit en relais d'un traitement parentéral : 4 mg/kg/jour en deux prises sans dépasser la posologie adulte (200 mg/jour). La durée du traitement est de 8 semaines lorsque l'exposition au charbon est avérée.

MODE D'ADMINISTRATION : Administrer au milieu d'un repas avec un verre d'eau (100 ml) et au moins une heure avant le coucher.

CONTRE-INDICATIONS

Absolue(s) :

Hypersensibilité aux cyclines

Enfant de moins de 8 ans

Grossesse, 6 derniers mois (de la)

Intolérance génétique au galactose

Déficit en lactase

Malabsorption du glucose et du galactose, syndrome (de)

Relative(s) : Allaitement

///DUPHASTON

Comment ça marche

Classe pharmacothérapeutique : PROGESTATIFS.

Action progestative:

--lutéomimétique au niveau de l'endomètre:

après imprégnation estrogénique, la hydrogestérone reproduit les stigmates de l'effet de la progestérone sur les glandes, les cellules sécrétoires et le système vasculaire de l'endomètre.

--Gestagène:

-absence d'effet androgénique ou estrogénique

-respect de la courbe thermique de l'ovulation.

Ses indications

Troubles des règles:

- o Irrégularités menstruelles post-pubertaires ou pré-ménopausiques,
- o Aménorrhées secondaires en dehors de la grossesse et après bilan.
- o Ménométrorragies.

Douleurs génitales:

- o Syndrome prémenstruel.
- o Dysménorrhée.

Endométriose.

Stérilité par insuffisance lutéale.

Ménopause confirmée (cycle artificiel en association avec un estrogène).

Mastopathies bénignes.

Sa posologie

Voie orale

En règle générale, pour le traitement de l'insuffisance lutéale: 20 mg / jour, soit 2 comprimés du 16^{ème} au 25^{ème} jour du cycle, en deux prises espacées.

Certaines indications nécessitent un mode d'emploi particulier:

• Endométriose:

3 comprimés / jour, en traitement continu ou discontinu (du 5e au 25e jour du cycle).

Les menstruations ne sont pas obligatoirement supprimées en cas de traitement continu.

• Ménométrorragies:

3 comprimés / jour jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie génitale plus 20 jours (pour éviter l'hémorragie de privation immédiate), puis 2 comprimés / jour du 16^{ème} au 25^{ème} jour des cycles suivants.

• Ménopause:

cycle artificiel en association avec un estrogène:

en règle générale, la posologie est de 1 à 2 comprimés par jour pendant les 12 à 14 derniers jours de la séquence estrogénique, chaque mois.

/// EXTENCILLINE benzathine benzylpénicilline

ANTIBIOTIQUES DU GROUPE DES PENICILLINES.

La benzathine benzylpénicilline est un antibiotique de la famille des b-lactamines du groupe des pénicillines de type G.

Ses indications

- . prophylaxie des rechutes du rhumatisme articulaire aigu,
- . traitement de la syphilis et du pian.

Posologie

A injecter par voie IM profonde exclusivement. Ne pas injecter par voie IV.

- Prophylaxie des rechutes du rhumatisme articulaire aigu :

1 injection IM tous les 15 jours de :

- . 2,4 MUI chez l'adulte ;
- . 600000 UI à 1,2 MUI chez l'enfant, selon l'âge.

- Cure des tréponématoses :

1 injection IM tous les 8 jours de 2,4 MUI.

ESPECES SENSIBLES :

- Aérobie à Gram positif : *Streptococcus*.
- Autres : Tréponème.

///Ferrosanol gyn

est une préparation à base de fer, destinée au traitement de la carence en fer.

Emballages de 50 capsules.

la dose usuelle pour les adultes et les enfants âgés de plus de 6 ans est de 1 capsule/jour.

En présence d'une carence en fer importante, les adultes de 15 ans et plus ou ayant un poids supérieur à 50 kg peuvent prendre au début 2 à 3 capsules réparties sur la journée. Les capsules sont à prendre avec suffisamment d'eau sans les mâcher. Les capsules devraient être prises à jeun ou suffisamment loin des repas, car l'assimilation du fer peut être entravée par les aliments (aliments végétaux, café, thé, lait).

Mdct semblables *Selofer Tardyferon Totihema*

///FLAGYL

Comprimé pelliculé à 250 mg (blanc) : Étui de 20.

Comprimé pelliculé à 500 mg (blanc) : Étuis de 4 et de 14.

Suspension buvable à 4 % : Flacon de 120 ml avec cuillère-mesure de 5 ml.

Solution injectable pour perfusion à 0,5 % : Poche souple de 100 ml, boîte de 25

Ovule à 500 mg (blanc) : Étui de 10

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTERIENS ANTIPARASITAIRES de la famille des nitro-5-imidazolés.

Ses indications

Elles procèdent de l'activité antiparasitaire et antibactérienne du métronidazole et de ses caractéristiques

pharmacocinétiques. Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :- amibiases,- trichomonases urogénitales,- vaginites non spécifiques,- lambliaoses,

- traitement curatif des infections médico-chirurgicales à germes anaérobies sensibles,

- relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.

sa posologie

- Amibiase :

Adultes :

1,50 g par jour en trois prises.

Enfants :

30 à 40 mg/kg/jour en trois prises.

Dans l'amibiase hépatique, au stade abcédairé, l'évacuation de l'abcès doit être effectuée conjointement au traitement par le métronidazole.

La durée du traitement est de sept jours consécutifs.

- Trichomonase :

chez la femme (urétrites et vaginites à Trichomonas), traitement à dose unique de **2 g en une seule prise (4 cp).**

Que le partenaire présente ou non des signes cliniques d'infestation à Trichomonas vaginalis, il importe qu'il soit traité concurremment, même en l'absence d'une réponse positive du laboratoire.

- Lambliaose :

. Adultes :

0,75 g à 1 g par jour pendant cinq jours consécutifs.

. Enfants de :

10 à 15 ans : 500 mg/jour.

- *Vaginites non spécifiques :*

500 mg 2 fois par jour pendant sept jours.

Un traitement simultané du partenaire doit être pratiqué.

- *Traitement des infections à germes anaérobies :*

(en première intention ou en traitement de relais)

. Adultes :

1 à 1,5 g/jour.

. Enfants :

20 à 30 mg/kg/jour.

///Fluconazol

50 mg : gélule (blanc et bleu pâle) ; boîte de 7.

100 mg : gélule (blanc et bleu clair) ; boîte de 7.

200 mg : gélule (blanc et bleu) ; boîte de 7.

200 mg : gélule (blanc et bleu) ; boîte de 30.

50mg/5ml poudre pour suspension buvable

2mg/ml solution pour perfusion

- Le fluconazole est un agent antifongique bistriazolé utilisable par voie orale et par voie injectable intraveineuse.

ESPECES HABITUELLEMENT SENSIBLES :

- Candida et en particulier albicans.

- Cryptococcus neoformans.

POSOLOGIE :

--- Chez l'adulte :

- Dans les candidoses oropharyngées des patients immunodéprimés, la dose est de : 50 mg une fois par jour pendant 7 à 14 jours.

Il est parfois nécessaire de prolonger le traitement à la même dose,

- Dans les candidoses buccales atrophiques liées aux prothèses dentaires, la dose est de : 50 mg une fois par jour pendant 14 jours en complément des soins d'hygiène locale.

--- Chez le prématuré, le nouveau-né à terme et jusqu'à 28 jours de vie : Leurs données cinétiques suggèrent une élimination plus lente dans cette tranche d'âge. Cependant, le caractère parcellaire et l'insuffisance des données cliniques ne permettent pas actuellement de proposer une posologie.

--- Chez le nourrisson et l'enfant :

- *Traitement des candidoses oropharyngées chez l'enfant immunodéprimé : la posologie recommandée est de 3 mg/kg/jour toutes les 24 heures.*
- *Traitement des candidoses systémiques, incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), candidoses oesophagiennes et candidoses urinaires : la posologie recommandée est de 6-12 mg/kg/jour toutes les 24 heures en fonction de la sévérité de la maladie.*
- *Traitement des cryptococcoses neuro-méningées ; le traitement d'entretien au cours du Sida doit être poursuivi indéfiniment : la posologie recommandée est de 6-12 mg/kg/jour toutes les 24 heures en fonction de la sévérité de la maladie*

GAVISCON

- *Comp à croq (légèrement tacheté, blanchâtre à crème) : Bte de 32, (Menthe ou Citron)*
- *Susp buvable: Sachets-dose de 10 ml, boîte de 12*
- *Comprimé à croquer (légèrement tacheté, blanchâtre à crème) : Pilulier de 20.*
- *Suspension buvable (crème) : Sachets-dose de 10 ml, boîte de 24.*
- *Suspension buvable (rose) : Flacon de 250 ml*
- *Suspension buvable : Flacon de 150 ml (pipette graduée en ml)*

INDICATIONS

Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

1 sachet ou 2 cuillères à café (soit 10 ml) 3 fois par jour après les 3 principaux repas et éventuellement le soir au coucher. Cette posologie peut être doublée en cas de reflux ou d'inflammation oesophagienne sévères.

Bien agiter le flacon et bien malaxer le sachet avant emploi.

/// Gelphe

Complément alimentaire riche en vitamines.

/// GENTAMICINE

ANTIBIOTIQUE DE LA FAMILLE DES AMINOSIDES.

- Sol p Perf :
1mg/ml(20FI/80ml);3mg/l(20FI/120ml) ;3mg/l(20FI/80ml)
- Pom opht 0.3% T/5mg
- Sol Inj 10mg ;160mg ;40mg ;80mg

Ses indications

- Bacilles Gram négatif définis comme sensibles, notamment dans leurs manifestations rénales et urologiques.
- L'association de la gentamicine avec un autre antibiotique
- . Rénales, urologiques et génitales,
- . Septicémiques et endocarditiques,
- . Méningées (en y adjoignant un traitement local),
- . Respiratoires,
- . Cutanées (staphylococcie cutanée maligne de la face),
- . Articulaires.
- Prophylaxie des infections post-opératoires :
en chirurgie urologique (résections endoscopiques de prostate, tumeurs endovésicales) ;
- . pour les patients allergiques aux bêtalactamines en :
- Prophylaxie médicale :
prophylaxie de l'endocardite infectieuse au cours des interventions urologiques et digestives, en association à l'amoxicilline, ou à un glycopeptide en cas d'allergie aux bêtalactamines.

POSOLOGIE :

Les posologies seront adaptées à la sévérité de l'infection, à l'état et à l'âge du malade.

- Chez le sujet normorénal :

- . Adultes : 3 mg/kg/jour en 2 ou 3 injections IM.
- . Enfants : 3 mg/kg/jour, en 3 inj IM (1 mg/kg ttes les 8 h).
- . Nourrissons :3 mg/kg/j, soit en 3 injIM (1 mg/kg ttes les 8 h), sous contrôle des taux sériques de l'antibiotique.
- . Nouveau-nés (à terme ou préma) :3 à 6 mg/kg/j, en 2 inj par voie IV en perfusion, sous contrôle des taux sériques de l'antib.

- Chez le sujet insuffisant rénal :

Il est indispensable de procéder à un ajustement de la posologie, de surveiller, de façon régulière, les fonctions rénale, cochléaire et vestibulaire et de pratiquer, dans toute la mesure du possible, des dosages sériques de contrôle.

MODE D'ADMINISTRATION :

La voie IM est la voie élective. Lorsque la voie IM est impraticable, on peut utiliser la voie IV en perfusion discontinue : la quantité de Gentamicine à administrer est de 1 mg/kg à diluer dans du sérum physiologique ou glucosé isotonique à raison d'au moins 1 ml de sérum pour 1 mg d'antibiotique soit, chez l'adulte : de 100 à 200 ml de sérum environ. Cette perfusion doit durer entre 30 et 60 minutes et être renouvelée :

- toutes les 8 heures chez le normoréal,
- à des intervalles de temps plus prolongés chez l'insuffisant rénal

ESPECES SENSIBLES :

-Aérobies à Gram(+)^f : *Corynebacterium*.. *Listeria monocytogenes*. *Staphylococcus méti-S*. *Staphylococcus méti-R** (40-60%).

- Aérobies à Gram(-)^f : *Acinetobacter* (50-75%).. *Branhamella catarrhalis*.. *Campylobacter*.. *Citrobacter freundii*.. *Citrobacter koseri*.. *Enterobacter aerogenes* (40-70%).. *Enterobacter cloacae* (0-15%).. *Escherichia coli*.. *Francisella*.. *Haemophilus influenzae*.. *Klebsiella* (0-10%).

. *Morganella morganii*. *Proteus mirabilis* (0-20%). *Proteus vulgaris*.. *Pseudomonas aeruginosa* (5-40%). *Salmonella*. *Serratia* (5-30%).. *Shigella*.. *Yersinia* . *Bartonella*.

///Gestarelle

Capsule : Boîte de 30

Complément alimentaire apportant vitamines, minéraux et oméga 3 pour une grossesse équilibrée (vitamine B9) et pour le bon développement du fœtus (DHA).

1 capsule par jour au milieu du déjeuner, dès le désir d'enfant et pendant toute la grossesse.

///Gracial

est une préparation hormonale contraceptive; ces préparations sont également connues sous le nom de contraceptifs oraux combinés ou de «pilules» contraceptives combinées. Du fait de sa faible teneur en hormones. Outre son activité contraceptive, la pilule oestroprogestative peut exercer d'autres effets favorables. Les règles peuvent être moins abondantes et durer moins longtemps, ce qui apporte une protection contre la carence en fer; les douleurs menstruelles sont moins intenses ou disparaissent entièrement.

///Indocid

Gélule à 75 mg (imprimé « MSD 693 », corps transparent et coiffe jaune opaque) : Boîte de 20, sous plaquettes thermoformées.

Gélule à 25 mg (imprimé « MSD 25 », ivoire) : Boîte de 30, sous plaquettes thermoformées.

Suppositoire à 50 mg et à 100 mg : Boîtes de 10, sous films thermosoudés.

C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte contre l'inflammation et la douleur, fait baisser la fièvre et fluidifie le sang.

INDICATIONS

Elles sont limitées, chez l'adulte (plus de 15 ans).

Traitement symptomatique au long cours de :

- ❖ *Rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment PR, spondylarthrite ankylosante ;*
- ❖ *Certaines Arthroses invalidantes et douloureuses.*

Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës

- ❖ *Rhumatismes abarticulaires (périarthrites scapulo-humérales, tendinites, bursites) ;*
- ❖ *Arthrites microcristallines ;*
- ❖ *Radiculalgies sévères ;*
- ❖ *Arthroses*

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

2 à 6 gélules à 25 mg ou 1 à 3 suppositoires à 50 mg (50 à 150 mg d'indométacine) par jour, en doses fractionnées, modulées en fonction de la réponse et de la tolérance du patient, ou 1 suppositoire à 100 mg par jour.

La posologie peut exceptionnellement atteindre 8 gélules à 25 mg ou 4 suppositoires à 50 mg ou 2 suppositoires à 100 mg (200 mg d'indométacine) par jour, notamment en cas d'arthrites microcristallines : 150 à 200 mg/jour d'indométacine en doses fractionnées jusqu'à disparition de la crise.

Chez le malade souffrant la nuit ou avec une raideur matinale, une dose plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 mg d'indométacine le soir au coucher est envisageable (gélule).

Une diminution des doses doit être envisagée chez le sujet âgé et chez l'insuffisant rénal.

Mode d'administration :

Il est conseillé de prendre les gélules d'Indocid au milieu d'un repas afin d'améliorer la tolérance digestive.

Le choix de la voie rectale n'est déterminé que par la commodité d'administration du médicament.

Se laver les mains après manipulation du suppositoire.

Durée d'administration :

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité locale surajoutée aux risques de la voie orale.

CONTRE-INDICATIONS

- ❖ A partir du 6^e mois de grossesse
- ❖ ATCD d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce mdc ou de sbces d'activité proche telles qu'autres AINS, aspirine.
- ❖ Antécédent d'allergie à l'un des excipients.
- ❖ Ulcère gastroduodénal en évolution.
- ❖ Hémorragie gastro-intestinale.
- ❖ Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- ❖ Insuffisance rénale sévère.
- ❖ Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
- ❖ ATCD récents de rectite ou de rect^{ragies} (lié à la forme sup)
- ❖ Enfant de moins de 15 ans.

///Lactacyd

LACTACYD Femina est une mousse onctueuse pour la toilette intime féminine à usage externe.

Flacon de 150 mL.

///LARGACTIL

- ❖ *Comprimé pelliculé sécable à 25 mg (orangé) : Étui de 50.*
- ❖ *Comprimé pelliculé sécable à 100 mg (orangé) : Étui de 30.*
- ❖ *Solution buvable à 4 % : Flacon compte-gouttes de 30 ml (1200 gouttes).*
- ❖ *Modèle hospitalier : Flacon de 125 ml avec seringue doseuse (5000 gouttes).*
- ❖ *Solution injectable à 25 mg/5 ml : Ampoules de 5 ml, boîte de 5.*

C'est un neuroleptique qui appartient à la famille chimique des phénothiazines. Il possède des effets atropiniques marqués, qui ne participent pas à son activité, mais qui expliquent certaines contre-indications et certains effets indésirables. Il est utilisé dans le traitement de certains troubles psychiques (schizophrénie, différents types de psychoses et les troubles graves du comportement chez l'enfant...).

Contre Indication

Risque de glaucome à angle fermé,

Risque de blocage des urines (adénome de la prostate),

Antécédent d'agranulocytose, En association avec les médicaments dopaminergiques ou avec le Sultopride,

Allergie aux sulfites (solution injectable)

///LEVOTHYROX

Lévothyroxine sodique

Ses indications

- hypothyroïdies,

- circonstances, associées ou non à une hypothyroïdie, où il est nécessaire de freiner la TSH.

///LOVENOX ANTI-THROMBOTIQUES (HBPM)

-Sol inj SC et intravasculaire à 2000 UI anti-Xa/0,2 ml (correspondant à 20 mg/0,2 ml) et à 4000 UI anti-Xa/0,4 ml (corresp à 40 mg/0,4 ml) :

Seringues préremplies avec système de sécurité, boîtes de 2 et de 6.

-Sol inj SC, IV, à 6000 UI anti-Xa/0,6 ml (corresp à 60 mg/0,6 ml), et à 8000 UI anti-Xa/0,8 ml (correspondant à 80 mg/0,8 ml) : Seringues préremplies avec système de sécurité, boîtes de 2 et de 10.

-Solution injectable SC, IV, à 10 000 UI anti-Xa/1 ml (correspondant à 100 mg/1 ml) : Seringues préremplies avec système de sécurité, boîte de 10. -

Solution injectable SC et intravasculaire à 30 000 UI anti-Xa/3 ml (correspondant à 300 mg/3 ml) : Flacon multidose, boîte unitaire.

Ses indications

Cette héparine est une héparine de bas poids moléculaire

Ses indications sont les suivantes :

//////// **T**raitement prophylactique de la maladie thrombo-embolique veineuse en chirurgie, dans les situations à risque modéré ou élevé ;

//////// **T**raitement prophylactique des thromboses veineuses profondes chez les patients alités pour une affection médicale aiguë .

---- une insuffisance cardiaque de stade III ou IV de la classification NYHA,

---- une insuffisance respiratoire aiguë,

---- ou un épisode d'infection aiguë ou d'affection rhumatologique aiguë, associé à au moins un autre facteur de risque thromboembolique veineux ;

//////// **P**révention de la coagulation du circuit de circulation extracorporelle au cours de l'hémodialyse (séance en général d'une durée ≤ 4 heures).

///Loxen

Nicardipine chlorhydrate

20 mg Comprimé sécable Boîte de 90

50 mg gel LP

10mg/10ml Sol Inj IV

C'est un vasodilatateur qui appartient à la famille des inhibiteurs calciques. Il est utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Dans le traitement de l'urgence hypertensive, la dose sera adaptée de manière à ce que la baisse de pression artérielle ne dépasse pas 25 % du niveau initial dans l'heure suivant l'institution du traitement injectable ; en effet, une chute trop abrupte de pression peut entraîner une ischémie myocardique, cérébrale ou rénale.

L'effet antihypertenseur est fonction de la dose administrée.

Pour un effet rapide :

administration intraveineuse directe, après dilution dans une solution glucosée à 5 %, à la vitesse de 1 mg/min, jusqu'à une dose cumulée de 10 mg, ou administration intraveineuse directe d'une dose de 2,5 mg renouvelable après 10 minutes jusqu'à une dose cumulée de 10 mg.

Pour un effet plus progressif : perfusion intraveineuse en dilution dans une solution glucosée à 5 %, à la vitesse de 8 à 15 mg/h sur 30 minutes.

Le relais dans l'un et l'autre cas est possible par une perfusion continue à la vitesse de 2 à 4 mg/h, avec adaptation des doses par paliers de 0,5 mg/h.

Le relais peut être également pris soit par Loxen 20 mg, à la dose de 60 mg par jour, en 3 prises quotidiennes, soit par Loxen LP 50 mg en 2 prises quotidiennes.

Posologie chez le nourrisson : 1 à 2 mg/m² de surface corporelle en 5 minutes.

///LUTENYL

PROGESTATIFS.

Ses indications

En association à un estrogène dans le cadre d'un Traitement Hormonal Substitutif (THS), chez des femmes ménopausées et non hystérectomisées.

Comment ça marche

- L'acétate de nomégestrol est un progestatif de synthèse dérivé de la 19-norprogestérone. Dépourvu d'activité androgénique et estrogénique, l'affinité de l'acétate de nomégestrol pour le récepteur de la progestérone est 2,5 fois supérieure à celle de l'hormone naturelle.

- Les estrogènes stimulent la croissance de l'endomètre et majorent le risque d'hyperplasie et de cancer de l'endomètre. L'association d'un progestatif chez les femmes non hystérectomisées entraîne une réduction importante du risque d'hyperplasie de l'endomètre induit par les estrogènes.

Sa posologie Voie orale

- La posologie habituelle est de 1 comprimé de LUTENYL 3,75 mg par jour, 12 à 14 jours par mois.

- Toutefois les modalités de traitement y compris la durée doivent être individuellement adaptées en fonction des symptômes cliniques, de la posologie de l'estrogène associé et de la réponse au traitement.

- L'oubli d'un comprimé peut favoriser la survenue de spotting et de saignements.

///MÉTHERGIN Méthylergométrine.

Ce médicament est un utérotonique (il provoque des contractions de l'utérus) qui appartient à la famille des dérivés de l'ergot de seigle. Il est utilisé pour lutter contre les hémorragies de l'utérus, après un accouchement, une césarienne ou une interruption de grossesse.

0,2 mg/ml : solution injectable ; boîte de 3 ampoules

0,25 mg/ml : Solution buvable en gouttes Flacon avec mesurette graduée de 10 ml.

0,125 mg : comprimé (jaune pâle) ; boîte de 20

INDICATION

-En relais des ocytociques par voie parentérale, dans les hémorragies de la délivrance et du post-partum liées à une atonie utérine. La forme orale n'est pas adaptée à la phase aiguë en cas d'urgence,

- métrorragies de suites de couches liées à une atonie utérine, en l'absence de rétention placentaire,

- métrorragies après avortement spontané en l'absence de rétention placentaire,

- métrorragies succédant à une interruption de grossesse par aspiration ou curetage,

- retours de couches hémorragiques,

- traitement d'appoint des ménorragies, en dehors de la grossesse, après bilan étiologique.

CONTRE-INDICATIONS

-  Allergie aux dérivés de l'ergot de seigle ;
-  Hypertension artérielle grave, insuffisance coronarienne, artérite ;
-  Infection grave ;
-  En Association avec les antimigraineux de la famille des triptans, les antirétroviraux, certains antifongiques ou les antibiotiques de la famille des macrolides ;
-  Grossesse.

La solution injectable ne doit jamais être administrée par voie intraveineuse.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau.

La solution inj^{ble} doit être administrée par voie IM.

Posologie usuelle:

- 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour.
- 1 ampoule injectable après la délivrance.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

- ❖ Nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- ❖ Troubles dus à l'effet vasoconstricteur du médicament, apparaissant surtout à fortes doses : augmentation de la tension artérielle, ralentissement ou accélération du cœur, douleurs d'angine de poitrine, fourmillements, engourdissement des extrémités.
- ❖ Éruption cutanée, maux de tête, vertiges.
- ❖ Exceptionnellement : choc anaphylactique

///MINIDRIL

Ses indications

Contraception hormonale orale.

Sa posologie Prendre régulièrement et sans oubli 1 comprimé blanc par jour au même moment de la journée, pendant 21 jours consécutifs avec un arrêt de 7 jours entre chaque plaquette.

Une hémorragie de privation débute habituellement 2 à 3 jours après la prise du dernier comprimé et peut se poursuivre après le début de la plaquette suivante.

Comment ça marche

PROGESTATIFS ET ESTROGENES EN ASSOCIATION FIXE

Estroprogestatif combiné minidosé, monophasique.

Indice de Pearl : 0,1 pour cent années femmes.

L'efficacité contraceptive de MINIDRIL résulte de trois actions complémentaires :

- au niveau de l'axe hypothalamohypophysaire par inhibition de l'ovulation,
- au niveau de la glaire cervicale qui devient imperméable à la migration des spermatozoïdes,
- au niveau de l'endomètre, qui devient impropre à la nidation

///Misoprostol (Cytotec®)

Classe thérapeutique **Gastro-Entéro-Hépatologie**

200 microgrammes : comprimé sécable (hexagonal ; blanc) ; bote de 60

Le misoprostol est un médicament anti-ulcéreux qui a également la propriété de provoquer des contractions et la maturation du col de l'utérus. Il est fréquemment utilisé pour l'avortement médicamenteux, en particulier dans les pays en développement. Il est cependant contre-indiqué par son fabricant pour le déclenchement des acc^{ments}. Malgré cela, il est utilisé très fréquemment pour cette indication en raison de son faible coût et de sa facilité de conservation, y compris dans les pays développés. Cette utilisation est controversée en raison d'effets secondaires parfois graves, et son administration, bien qu'elle soit hors autorisation de mise sur le marché, se fait le plus souvent sans informer les femmes des risques, bénéfices et alternatives de cette méthode de déclenchement. Cette méthode nécessite également une surveillance importante par monitoring, ainsi que la présence d'un obstétricien et d'un anesthésiste, afin d'intervenir en pratiquant une césarienne d'urgence, si nécessaire. En comparaison des autres techniques mentionnées ici, son action est très difficilement réversible.

Les effets secondaires sont notamment la nausée, les vomissements, la diarrhée et les douleurs nécessitant des analgésiques.

///NEPRESSOL®

Vasodilatateur artériolaire, antihypertenseur

Poudre et solvant pour solution injectable à 25 mg/2 ml : Ampoules de poudre et ampoules de solvant de 2 ml, boîte de 5

INDICATIONS

Certaines pré-éclampsies graves mettant en jeu le pronostic vital maternel.

En l'absence de contre-indication, Nepressol sera administré en association à un bêtabloquant.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION *Perfusion intraveineuse à la pompe ou administration en bolus (éventuellement suivie d'une perfusion continue).*

Nepressol injectable doit être administré de préférence en perfusion intraveineuse continue à la pompe. La posologie recommandée est de 50 à 100 mg par 24 heures, établie de façon progressive. La posologie initiale est de 2 ampoules (soit 50 mg) diluées dans 500 ml de solution de sérum physiologique. Le débit de perfusion est adapté à chaque cas individuel, en fonction de l'évolution des chiffres tensionnels et de la tolérance hémodynamique.

La dose sera adaptée de manière à ce que la baisse de pression artérielle ne dépasse pas 25 % du niveau initial dans l'heure suivant l'institution du traitement injectable ; en effet, une chute trop abrupte de pression peut entraîner une ischémie myocardique, cérébrale ou rénale.

En général, le débit de perfusion ne dépasse pas 0,5 mg/min (30 mg/h).

Un abaissement progressif et durable de la pression diastolique à 90-100 mm Hg peut être considéré comme une réponse satisfaisante.

La durée du traitement est adaptée à chaque cas particulier.

En cas de nécessité d'injection IV, la dose initiale est de ¼ d'ampoule (6,25 mg) injecté lentement en 2 à 4 minutes, afin d'éviter tout abaissement brutal de la pression artérielle.

S'il est nécessaire de réitérer l'injection, un intervalle libre de 20 à 30 minutes sera observé avant d'administrer une nouvelle dose de 6,25 mg en bolus, sous contrôle continu de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque.

CONTRE-INDICATIONS

Antécédents d'hypersensibilité à l'hydralazine ou à la dihydralazine.

Mises en garde :

En raison du risque de menace, voire de mort foetale, la baisse tensionnelle devra être progressive et toujours contrôlée.

Précautions d'emploi :

Avant administration, la correction d'une éventuelle hypovolémie sera assurée.

L'administration se fera sous remplissage vasculaire, si nécessaire.

Une prudence particulière s'impose en cas d'insuffisance cardiaque associée.

EFFETS INDÉSIRABLES

Ont été rapportés chez la mère :

céphalées ;

tachycardie, palpitations, flush, hypotension artérielle, rétention hydrosodée ;

exceptionnellement : douleurs angineuses, troubles du rythme ventriculaire ;

exanthème, prurit ; nausées, vomissement

///NIBIOL

100 mg Comprimé enrobé Boîte de 50

Indications

Traitement des infections urinaires basses non compliquées à germes sensibles principalement chez la jeune femme.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

SPECTRE :

- espèces sensibles : Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida sp dont tropicalis, krusei, parapsilosis et torulopsis sp dont glabrata.

- espèces inconstamment sensibles : Proteus, Staphyloques.

Posologie

- Adulte à partir de 15 ans :

600 mg/jour en 3 prises avant les repas.

- Enfant à partir de 6 ans :

20 mg/kg/j en 3 prises avant les repas, soit 1 comprimé par 5 kg de poids.

- Insuffisant rénal : clairance de la créatinine supérieure à 20 ml/min : réduire la posologie de moitié,

. clairance de la créatinine inférieure à 20 ml/min : l'utilisation de la nitroxoline est contre-indiquée.

- Insuffisant hépatique : diviser la posologie de moitié.

Contre indications

- Insuffisance rénale (clairance de la créatinine inférieure à 20 ml/min).

- La nitroxoline ne doit pas être prescrite en association avec d'autres médicaments contenant des hydroxyquinoléines ou leurs dérivés.

Effets indésirables

Troubles digestifs mineurs.

OFLOXACINE

200 mg : comprimé sécable ; boîte de 10

200 mg/40ml sol inj p perf réservées au secteur hospitalier et limitées chez l'adulte aux infections sévères à bacilles à Gram négatif et à staphylocoques définis comme sensibles.

INDICATIONS

l'adulte :

- traitement des infections urinaires hautes et basses,
- traitement de l'urétrite gonococcique et non gonococcique,
- traitement des infections sévères dans les manifestations prostatiques,
- traitement des infections gynécologiques hautes,
- traitement de relais des infections ostéoarticulaires,
- traitement de la suppuration bronchique, en l'absence de toute atteinte parenchymateuse :

. chez le sujet à risque (éthylisme chronique, tabagisme, sujet de plus de 65 ans),

. chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives,

- traitement des infections ORL suivantes :

- . sinusites chroniques,
- . poussées de surinfection des otites chroniques (quelle que soit leur nature) et des cavités d'évidement,
- . préparations pré-opératoires d'otites chroniques ostéitiques ou cholestéatomateuses.

Elles sont réservées au secteur hospitalier et limitées chez l'adulte aux infections sévères à bacilles Gram négatif et staphylocoques définis comme sensibles dans leurs manifestations :

- septicémiques, - respiratoires, - ORL chroniques, - rénales et urinaires, y compris prostatiques, - gynécologiques, - osseuses et articulaires, - cutanées, - abdominales et hépatobiliaires.

Situation particulière : *Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.*

Les streptocoques et pneumocoques n'étant que modérément sensibles à l'ofloxacine, le produit ne doit pas être prescrit en première intention lorsque l'un de ces germes est suspecté.

Au cours du traitement d'infections à Pseudomonas aeruginosa et à Staphylococcus aureus, l'émergence de mutants résistants a été décrite et peut justifier l'association d'un autre antibiotique.

Une surveillance microbiologique à la recherche d'une telle résistance doit être envisagée, en particulier en cas de suspicion d'échec. L'emploi d'ofloxacine dans les infections graves, notamment bactériémiques à Pseudomonas aeruginosa et acinetobacter, est déconseillé.

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

---- Adultes :

400 mg/jour en deux prises (soit 1 comprimé matin et soir).

- Pour le traitement de la suppuration bronchique, la posologie est de 400 mg/jour en une seule prise.

Cette posologie peut être augmentée jusqu'à 600 ou 800 mg/jour chez des malades de poids élevé, et/ou en cas d'infections sévères, notamment chez l'immunodéprimé, ou en cas d'infection d'origine nosocomiale à germes Gram négatif multirésistants tels que pseudomonas, acinetobacter et serratia.

- Pour ces derniers germes ainsi que pour Staphylococcus aureus, l'association à un autre antibiotique, adapté au germe causal, est recommandée.

- Pour le traitement des infections gynécologiques hautes, la durée du traitement sera de 3 semaines.

- Dans les infections urinaires basses de la femme, trois situations sont envisageables :

. cystites aiguës non compliquées de la femme de moins de 65 ans : 2 comprimés en une seule prise.

*. cystites de la femme présentant les facteurs de risque suivants :
cystites récidivantes, âge supérieur à 65 ans :
le traitement est de 5 jours.*

. dans les autres cas d'infection urinaire basse (stase ou dilatation des voies urinaires par anomalie anatomique ou fonctionnelle, infection sur sonde, immunodépression, diabète, échec d'un traitement antibiotique antérieur), les schémas raccourcis ne s'appliquent pas.

Situation particulière : *Maladie du charbon : traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif des personnes symptomatiques pouvant recevoir un traitement per os, soit d'emblée, soit en relais d'un traitement parentéral : 800 mg/jour en deux prises. La durée du traitement est de 8 semaines lorsque l'exposition au charbon est avérée.*

CONTRE-INDICATIONS

- ✓ *Tendinopathie due à une fluoroquinolone, antécédent (de)*
- ✓ *Hypersensibilité aux quinolones*
- ✓ *Epilepsie*
- ✓ *Déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase*
- ✓ *Enfant de moins de 6 ans*
- ✓ *Allaitement*
- ✓ *Intolérance génétique au galactose*
- ✓ *Déficit en lactase*
- ✓ *Malabsorption du glucose et du galactose, syndrome (de)*
- ✓ *Relative(s) :*
- ✓ *Enfant jusqu'à la fin de la période de croissance*

OMEPRAZOL

10 mg : gélule gastrorésistante ; bte de 14 ; de 28.

20 mg : gélule gastrorésistante ; bte de 7 ; 14 ; 28.

40mg pdre p sol p perf

INDICATIONS *Adulte* : - Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien, associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance ou d'inadaptation des traitements de première intention (conseil hygiéno-diététiques, antiacides, alginates).

- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux.

- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par *Helicobacter pylori* ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.

Enfant à partir d'un an :

- Oesophagite érosive ou ulcérate sympt^{que} par reflux gastro-oesophagien.

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

Les gélules peuvent être prises au cours d'un repas ou à jeun.

Adulte :

- reflux gastro-oesophagien : 1 gélule dosée à 10 mg par jour.

La posologie pourra être portée à 20 mg en cas de réponse insuffisante.

La durée initiale du traitement est de 4 à 6 semaines.

Par la suite, un traitement intermittent pourra être administré au moment des périodes symptomatiques.

- oesophagites par reflux gastro-oesophagien : La dose minimale efficace doit être recherchée. Elle est de 10 à 20 mg par jour, adaptée en fonction de la réponse symptomatique et/ou endoscopique.

Dans les oeso^{gites} sévères, une posologie initiale de 20 mg est recommandée.

- ulcères duodénaux : La posologie est de 1 gélule dosée à 10 mg par jour. Elle sera portée à 20 mg, en cas d'inefficacité ou en cas de résistance à un traitement d'entretien par les anti-H2.

Enfant :

Oesophagite par reflux gastro-oesophagien : 1 mg/kg/jour, pendant 4 à 8 semaines, soit :

- enfant de 10 à 20 kg : 1 gélule d'oméprazole à 10 mg par jour.

Si nécessaire, cette dose peut être augmentée jusqu'à 20 mg par jour ;

- enfant de plus de 20 kg : 2 gélules d'oméprazole à 10 mg par jour.

Chez les enfants de moins de 6 ans (en raison du risque de fausse-route) et les enfants ne pouvant pas avaler les gélules, celles-ci doivent être ouvertes et

mélangées à un aliment légèrement acide ($\text{pH} < 5$), tel que : yaourt, jus d'orange, compote de pommes...

///ORGAMETRIL

Le lynestrénol est un progestatif de synthèse de type norstéroïde. Le lynestrénol a une action progestative puissante sur l'endomètre.
L'effet antigonadotrope, l'effet sur la glaire et sur l'endomètre permettent un effet contraceptif.
Il compense l'insuffisance en progestérone et a une action anti-estrogène.
Comprimé de 5 mg.

Ses indications

- Troubles liés à une insuffisance en progestérone et notamment ceux observés en période préménopausique (irrégularités menstruelles, syndrome prémenstruel, mastodynies).
- Hgies f(x)^{nelles} et ménorragies accompagnant les fibromes.
- Endométriose.
- Mastopathies bénignes.
- Disménorrhée.
- Contraception en 2ème intention chez les femmes présentant une contre-indication à la contraception estroprogestative.
- Cycle artificiel en association avec un estrogène.

Sa posologie

- Troubles liés à une insuffisance en progestérone:
 $2 \text{ Cp}^{\text{rimés}} / \text{j}$ du 10ème ou 15ème jour du cycle jusqu'au 25ème, voire du 5ème au 25ème jour du cycle, selon le cas.
- Hémorragies f(x)^{elles} et ménorragies: $2 \text{ Cp}^{\text{rimés}} / \text{j}$ du 16ème au 25ème jour du cycle.
- Endométriose : $1 \text{ à } 2 \text{ Cp}^{\text{rimés}} / \text{jour}$, sans interruption, pendant au moins 6 mois.
- Mastopathies bénignes : $1 \text{ à } 2 \text{ Cp}^{\text{rimés}} / \text{j}$ du 10ème ou 15ème jour du cycle, voire du 5ème au 25ème, selon la sévérité.
- Disménorrhée : $1 \text{ à } 2 \text{ Cp}^{\text{rimés}} / \text{j}$ du 16ème au 25ème jour du cycle. En cas d'inefficacité : $2 \text{ Cp}^{\text{rimés}}$ du 5ème au 25ème jour du cycle.
- Contraception en 2ème intention chez les femmes :

2 Cp^{rimés} / j du 5^{ème} au 25^{ème} jour du cycle.

- Cycle artificiel en association avec un estrogène :

1 Cp^{rimés} / j pendant les 12 à 14 derniers jours du traitement estrogénique.

NOTE

Conduite à tenir en cas d'oubli : Dans l'indication contraception, l'oubli d'un comprimé peut induire un risque de grossesse :

. Si l'oubli est constaté dans les 12 heures qui suivent l'heure habituelle de la prise, prendre immédiatement le comprimé oublié, et poursuivre le traitement normalement en prenant le comprimé suivant à l'heure habituelle.

. Si l'oubli est constaté plus de 12 heures après l'heure normale de la prise, la sécurité contraceptive n'est plus assurée. Procéder alors comme ci-dessus pour éviter une hémorragie de privation prématurée, mais utiliser simultanément une autre méthode contraceptive (préservatifs masculins, spermicides...) jusqu'à la fin de la plaquette en cours.

///OROKEN

PRÉSENTATIONS

OROKEN 200 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 8.

OROKEN Enfant 100 mg/5 ml : poudre pour suspension buvable (arôme fraise) ; flacon de 40 ml avec pipette doseuse graduée en kg.

OROKEN Nourrisson 40 mg/5 ml : poudre pour suspension buvable (arôme fraise) ; flacon de 40 ml avec pipette doseuse graduée en kg.

Le céfixime est un antibiotique de la famille des bêtalactamines, du groupe des céphalosporines dites de 3^e génération.

INDICATIONS

Cet antibiotique appartient à la famille des céphalosporines, antibiotiques proches des pénicillines, qui sont actives sur un plus grand nombre de germes que la pénicilline simple. Il est utilisé dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment des infections des poumons, des bronches, de la gorge, des sinus, des oreilles, de l'appareil urinaire et des infections génitales à gonocoques.

CONTRE-INDICATION

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux céphalosporines. Votre médecin est seul juge pour prescrire ce médicament en cas d'allergie aux pénicillines.

ATTENTION

La survenue de toute réaction allergique (boutons, oedème, malaise) impose l'arrêt du traitement : consultez rapidement votre médecin. Pensez à toujours signaler vos antécédents d'allergie à une céphalosporine ou à une pénicilline. De nombreux antibiotiques peuvent provoquer des selles liquides ou une diarrhée, généralement bénigne. En revanche, une diarrhée importante survenant pendant ou dans les jours qui suivent le traitement antibiotique doit être signalée à votre médecin. Une diminution de la fièvre ou une disparition des symptômes ne sont pas synonymes de guérison : la durée du traitement doit absolument être respectée pour éviter les rechutes ou l'apparition d'une résistance du germe à l'antibiotique. Les suspensions buvables contiennent du sucre (saccharose) en quantité notable.

MODE D'EMPLOI ET

Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas. La suspension buvable est reconstituée par addition d'eau jusqu'au trait de jauge. Agiter avant l'emploi. La pipette doseuse permet un ajustement précis de la posologie : la dose par prise est indiquée, en fonction du poids de l'enfant, sur le piston de la pipette graduée en kg. Par exemple, la graduation no 10 correspond à la dose à administrer par prise pour un enfant de 10 kg. 2 prises par jour sont nécessaires.

Posologie usuelle:

Adulte : 1 comprimé, matin et soir. Dans les infections génitales à gonocoques : une prise unique de 2 comprimés.

Enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé, matin et soir.

Enfant de 30 mois à 12 ans : 8 mg par kg et par jour, en 2 prises espacées de 12 heures ; soit, par exemple, pour un enfant de 12 kg : 1 pipette remplie de suspension buvable Enfant jusqu'à la graduation 10 kg et 1 pipette remplie jusqu'à la graduation 2 kg, 2 fois par jour.

Nourrisson de 6 à 30 mois : 8 mg par kg et par jour, en 2 prises espacées de 12 heures ; soit, par exemple, pour un nourrisson de 8 kg : 1 pipette remplie de suspension buvable Nourrisson jusqu'à la graduation 8 kg, 2 fois par jour.

///Ovestin

Indication

Les comprimés d'Ovestin contiennent une hormone appelée estriol, qui est identique à l'hormone sexuelle féminine naturelle. Ovestin est utilisé pour traiter les troubles qui surviennent pendant ou après la ménopause ou après l'ablation chirurgicale des ovaires. L'estriol améliore rapidement et durablement les troubles typiques provoqués par un déficit en estrogènes, comme par exemple les bouffées de chaleur et troubles liés à l'atrophie des organes génitaux féminins externes et internes, avec des symptômes tels que démangeaisons, douleurs lors des rapports sexuels ou émission involontaire d'urines et écoulement. On utilise aussi Ovestin comme traitement d'appoint des infections vaginales et pour la préparation aux opérations vaginales. De plus, Ovestin normalise la peau et les muqueuses des organes génitaux féminins externes et internes.

Posologie

suivant le degré de sévérité des symptômes, 4–8 comprimés à 1 mg par jour pendant la (les) première(s) semaine(s), puis réduction progressive jusqu'à la «dose d'entretien» qui est de 1–2 comprimés à 1 mg par jour. Pour les autres troubles, on peut utiliser une posologie moindre. La dose journalière totale doit toujours être prise en une seule fois. Avalez les comprimés avec un peu d'eau ou d'autre liquide, si possible toujours à la même heure de la journée

///PARLODEL

Gélule à 5 mg (bleu clair/blanc) ou à 10 mg (blanche) : Boîtes de 30, sous Comprimé sécable (blanc) 2.5mg : Boîte de 30

Ses indications

Endocrinologie

- Conséquences cliniques de l'hyperprolactinémie**

Chez la femme:

Troubles sévères du cycle menstruel (avec ou sans galactorrhée),

Stérilité,

Galactorrhée.

Chez l'homme :

Gynécomastie et impuissance.

Prolactinomes :

Traitement de fond des prolactinomes: micro ou macroadénomes,

En particulier préparation à l'acte chirurgical en cas de macroadénome où le

Parlodel peut favoriser l'intervention en réduisant le volume tumoral, notamment en cas d'extension extra-sellaire,

En cas d'échec précoce ou tardif de la chirurgie: réapparition d'une hyperprolactinémie.

Comment ça marche

Agoniste dopaminergique Inhibiteur de la sécrétion de prolactine

--Au niveau hypothalamo-hypophysaire, elle freine la sécrétion de la prolactine et réduit l'hyperprolactinémie, qu'elle soit d'origine physiologique (grossesse, post-partum) ou pathologique.

--La bromocriptine peut corriger la sécrétion inappropriée de l'hormone de croissance.

--Au niveau nigro-strié, par stimulation directe et prolongée des récepteurs dopaminergiques post-synaptiques, la bromocriptine pallie la déplétion en dopamine qui caractérise la maladie de Parkinson.

Sa posologie

Pour améliorer la tolérance digestive, l'administration du médicament doit toujours se faire au milieu des repas.

Endocrinologie

Le schéma thérapeutique est le suivant :

-- ½ comprimé le premier jour, 1 comprimé le 2ème jour, puis 2 comprimés par jour pendant plusieurs semaines.

Si après 6 semaines la fonction gonadique n'est pas restaurée la posologie peut être portée à 3 comprimés voire ultérieurement à 4 comprimés par jour.

PERFALGAN

analgésiques et antipyrétiques (du paracétamol).

Solution pour perfusion IV à 10 mg/ml (claire, légèrement jaune) : Flacons de 100 ml, boîte de 12.

Poches de 100 ml, boîte de 50

INDICATIONS

Traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période postopératoire, et traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie intraveineuse : Réservé à l'adulte, à l'adolescent et à l'enfant de plus de 33 kg.

Posologie :

Adulte et adolescent de plus de 50 kg : 1 g de paracétamol par administration, soit un flacon ou une poche de 100 ml, jusqu'à 4 fois par jour.

Respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre deux administrations.

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 4 g.

Enfant de plus de 33 kg (environ 11 ans), adolescent et adulte de moins de 50 kg : 15 mg/kg de paracétamol par administration, soit 1,5 ml de solution par kg, jusqu'à 4 fois par jour.

Respecter un intervalle d'au moins 4 heures entre deux administrations.

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g).

Mode d'administration :

La solution de paracétamol est administrée en perfusion intraveineuse de 15 minutes.

Flacons en verre :

Comme pour toutes les solutions pour perfusion conditionnées dans des flacons en verre, il est rappelé qu'une surveillance étroite est particulièrement recommandée à la fin de la perfusion quelle que soit la voie d'administration.

Cette surveillance à la fin de la perfusion s'applique tout particulièrement aux perfusions par voie centrale de façon à éviter une embolie gazeuse.

CONTRE-INDICATIONS

*Hypersensibilité au paracétamol ou au chlorhydrate de propacétamol (prodrogue du paracétamol), ou à l'un des excipients.
Insuffisance hépatocellulaire sévère.*

///POLYGYNAX

- ❖ *Capsule vaginale : Boîte de 6, sous plaquette thermoformée.*
- ❖ *Modèle hospitalier : Boîte de 60, sous plaquettes thermoformées.*

Ce médicament contient deux antibiotiques, la polymyxine B et la néomycine, de la famille des aminosides, et un antifongique, la nystatine.

INDICATIONS

Traitement local des vaginites à germes sensibles et des vaginites non spécifiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte. 1 cap vaginale le soir pendant 12 jours.

Conseils pratiques :

Le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales et le port de tampon interne pendant le traitement...) et, dans la mesure du possible, de la suppression des facteurs favorisants.

le trait du partenaire se discutera en fonction de chaque cas.

Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

INTERACTIONS



Contre-indiquées :

Préservatifs : risque de rupture des préservatifs.



Déconseillées :

Spermicides : tout traitement local vaginal est susceptible d'inactiver une contraception locale spermicide

///PROGYNOVA

1 mg Comprimé enrobé Boîte de 20 Comprimé rond biconvexe enrobé beige. 2mg Cp Bleu Bte de 20.

Ses indications

Traitement hormonal substitutif (THS)

Ce médicament contient une hormone naturelle de la famille des estrogènes. Il est utilisé pour soulager les symptômes dus au déficit en estrogènes lors de la ménopause (bouffées de chaleur, sécheresse vaginale...) et de certaines stérilités.

Les comprimés à 2 mg sont également utilisés pour prévenir l'ostéoporose chez la femme ménopausée ayant un risque accru de fracture.

CONTRE-INDICATIONS

-  *accident thromboembolique (phlébite, embolie pulmonaire,...) ancien ou survenant pendant le traitement ;*
-  *cancer hormonodépendant ;*
-  *saignement génital intermittent (l'origine de ce saignement doit être déterminée par des examens appropriés avant la mise en route du traitement) ;*
-  *maladie grave du foie*

ATTENTION *De récentes études ont montré une augmentation du risque de survenue d'un cancer du sein chez les femmes ayant reçu un traitement prolongé des symptômes de la ménopause.*

Sa posologie

Voie orale : habituellement 1 comprimé par jour.

En fonction de l'évolution clinique, la posologie peut être adaptée aux besoins individuels : l'apparition d'une sensation de tension des seins, d'une anxiété, d'une irritabilité indique en général que la dose est trop élevée et doit être diminuée.

Si la dose choisie n'a pas corrigé les symptômes de déficit estrogénique, il faut l'augmenter.

Pour débiter ou poursuivre un traitement dans l'indication des symptômes post-ménopausiques, la dose minimale efficace doit être utilisée pendant la plus courte durée possible .

PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé peut être utilisé selon le schéma thérapeutique :

- **Cyclique, (discontinu), pendant 20 à 25 jours, suivis d'un intervalle libre de tout traitement de 5 à 6 jours. Durant cet intervalle, des hémorragies de privation peuvent apparaître.**

- **Continu, sans aucune période d'arrêt du traitement.**

Un traitement continu, non cyclique, peut être indiqué chez les femmes dans le cas où les symptômes de déficit estrogénique se manifestent à nouveau fortement au cours de l'intervalle libre.

S'il s'agit d'une prescription chez une femme ne prenant pas de THS ou d'un relais d'un THS combiné continu, le traitement peut être commencé n'importe quel jour.

Par contre, si le traitement préalable est un THS séquentiel, le cycle de traitement en cours doit être terminé avant de commencer un traitement par PROGYNOVA 1 mg, comprimé enrobé.

Chez les femmes non hystérectomisées, un progestatif doit être ajouté pour s'opposer au développement d'une hyperplasie endométriale induite par l'estrogène. Le traitement séquentiel par des progestatifs doit se faire selon le schéma suivant :

- **Si le traitement est administré de façon continue, il est recommandé de prendre le progestatif au moins 12 jours chaque mois.**

- **Si le traitement est administré de façon discontinue, le progestatif sera administré durant au moins les 12 derniers jours du traitement par l'estradiol. Ainsi, il n'y aura aucune administration hormonale pendant l'intervalle libre de chaque cycle. Dans les deux cas, des saignements peuvent apparaître après l'arrêt du traitement par le progestatif.**

Chez les femmes hystérectomisées, il n'est pas recommandé d'associer un progestatif sauf en cas d'antécédent d'endométriose.

En cas d'oubli d'un comprimé, celui-ci doit être pris dans les 12 heures suivant l'heure habituelle de la prise.

L'oubli d'un comprimé peut favoriser la survenue de spotting et saignements.

RIABAL

Riabal 100 Mg, Suppositoire

Riabal 15 Mg/2 Ml, Solution Injectable en Ampoule

Riabal Enfants, Solution Buvable

Riabal Retard 70 Mg, Comprime

Indications de Riabal

indications

Manifestation fonctionnelle digestive

Colopathie spasmodique douleur

Nausee et vomissement non induits par anticancereux

Ce médicament a été retiré du marché ?????

/// ROVAMYCINE *Spiramycine*

Antibiotique antibactérien des macrolides.

Cp : 1.5MUI Bte 16,3MUI Bte 10-100-16

Poudre : 1.5MUI p us parent

Ses indications

- angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, en alternative au traitement par bêtalactamines, particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé.

- sinusites aiguës.

- surinfections des bronchites aiguës.

- exacerbations des bronchites chroniques.

- pneumopathies communautaires chez des sujets :

. sans facteurs de risque,

. sans signes de gravité clinique,

. en l'absence d'éléments cliniques évocateurs d'une étiologie

pneumococcique.

En cas de suspicion de pneumopathie atypique, les macrolides sont indiqués quels que soient la gravité et le terrain.

- infections cutanées bénignes : impétigo, impétiginisation des dermatoses, ecthyma, dermo-hypodermite infectieuse (en particulier, érysipèle), érythrasma.

- infections stomatologiques.

- infections génitales non gonococciques.

- chimioprophylaxie des rechutes du RAA en cas d'allergie aux bêtalactamines.

- toxoplasmose de la femme enceinte.
- prophylaxie des méningites à méningocoque en cas de contre-indication à la rifampicine :
 - . le but est d'éradiquer le germe (*Neisseria meningitidis*) du nasopharynx,
 - . la spiramycine n'est pas un traitement de la méningite à méningocoque,
 - . elle est préconisée en prophylaxie chez :
 - le malade après son traitement curatif et avant sa réintégration en collectivité,
 - les sujets ayant été exposés aux sécrétions oropharyngées dans les dix jours précédant son hospitalisation.

Posologie :

- Chez le sujet aux fonctions rénales normales :
 - . Ce dosage n'est pas adapté à l'enfant. Il est réservé à l'adulte.
 - 6 à 9 millions d'UI/24 heures, soit 2 à 3 comprimés par jour en 2 à 3 prises.
 - . Durée du traitement : La durée du traitement des angines est de 10 jours.
- Prophylaxie des méningites à méningocoque :
 - 3 millions d'UI/12 heures pendant 5 jours.
- Chez le sujet insuffisant rénal :
 - Aucun ajustement posologique n'est nécessaire.
 - Les comprimés sont à avaler tels quels avec un verre d'eau.

ESPECES SENSIBLES :

- Aérobie à Gram positif : *Bacillus cereus*.. *Corynebacterium diphtheriae*..
Entérocoques (50-70%).. *Rhodococcus equi*.
- . *Staphylococcus méti-S*.. *Staphylococcus méti-R** (70-80%).
- . *Streptococcus B*.. *Streptococcus non groupable* (30-40%).
- . *Streptococcus pneumoniae* (35-70%).. *Streptococcus pyogenes* (16-31%).
- Aérobie à Gram négatif : *Bordetella pertussis*.. *Branhamella catarrhalis*..
Campylobacter.. *Legionella*.. *Moraxella*.
- Anaérobies : *Actinomyces*.. *Bacteroides* (30-60%).. *Eubacterium*.
- . *Mobiluncus*.. *Peptostreptococcus* (30-40%).. *Porphyromonas*.
- . *Prevotella*.. *Propionibacterium acnes*.
- Autres : *Borrelia burgdorferi*.. *Chlamydia*.. *Coxiella*.. *Leptospirae*.
- . *Mycoplasma pneumoniae*.. *Treponema pallidum*.

///SAFORELLE

AGENT NETTOYANT.

Ses indications

Soins gynécologiques externes en milieu neutre.

Sa posologie

Une dose d'environ 2 ml est utilisée, matin et soir, pendant 5 à 7 jours. Mode d'utilisation :

- . Se laver les mains, puis mouiller la région périnéale à l'eau.
- . Recueillir la solution dans la paume de la main par pressions successives sur la pompe, et appliquer doucement sur la peau et les muqueuses mouillées. Ne pas utiliser de gant de toilette.
- . Rincer abondamment à l'eau pendant environ 1 minute.
- . Sécher sans frotter.
- Conseils pratiques :

Le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales, le port de vêtements trop serrés, le port de tampon interne pendant le traitement...).

///Salbutamol

5mg/5ml sol Inj et sol pour perf

Comp 2mg boîte de 40

Indication

--Pneumologie :

voie intraveineuse en perfusion continue : traitement de l'asthme aigu grave (état de mal asthmatique).

--Obstétrique :

-  Menace d'accouchement prématuré.
-  Dystocie dynamique de démarrage.
-  Hypercinésie lors du travail.
-  Tocolyse précésarienne.



Prophylaxie des contractions lors d'interventions chirurgicales sur utérus gravide au-delà de la 12ème semaine d'aménorrhée.

POSOLOGIE

--Obstetrique :

Traitement d'urgence : Il se fait chez la femme hospitalisée, au repos, placée en décubitus latéral gauche. Il est recommandé de pratiquer un électrocardiogramme avant la mise en place de la perfusion .

Le risque exceptionnel de survenue d'un oedème aigu du poumon doit faire préférer l'administration par seringue électrique (lorsqu'elle est possible) à la perfusion, afin de limiter les volumes administrés.

Dans le cas où l'administration serait réalisée au moyen d'une perfusion, la vitesse de perfusion ne devrait pas dépasser 1,5 l de volume total perfusé par 24 heures. Préparer alors une solution titrant 20 µg/ml en diluant, par exemple, 2 ampoules de SALBUTAMOL MERCK 5 mg/5 ml, soit 10 mg de salbutamol, dans 500 ml de solution isotonique salée ou glucosée.

Quel que soit le mode d'administration employé, le débit initial sera de 15 à 20 µg/min (soit 15 à 20 gouttes/min dans le cas d'une perfusion titrant 20 µg/ml). S'il y a lieu, ce débit peut être augmenté progressivement, par paliers de 5 à 10 µg/min toutes les 10 minutes.

En règle générale, le débit d'entretien efficace est inférieur au débit initial, et compris en moyenne entre 10 et 20 µg/min.

Surveiller le pouls (qui doit rester inférieur à 140 bat/min) ainsi que la pression artérielle à intervalles rapprochés. Maintenir encore le débit pendant l'heure qui suit l'arrêt des contractions puis le diminuer à la dose minimale efficace pour maintenir ce résultat jusqu'au lendemain. **Traitement d'entretien :** Le traitement d'entretien pourra être assuré par d'autres formes destinées à être administrées par voies sous-cutanée, intra-musculaire, orale ou rectale.

CONTRE-INDICATIONS



Infection intra-amniotique



Hémorragie utérine



Grossesse dont la poursuite fait courir un risque à la mère ou à l'enfant

-  **Cardiopathie** sévère susceptible d'être décompensée par un bêta-2-stimulant
-  **Hyperthyroïdie**
-  **Hypertension artérielle sévère non contrôlée**
-  **Hypertension gravidique**
-  **Eclampsie**
-  **Toxémie gravidique**

///Sapofen

Analgésique & Anti Inflammatoire

Ses indications anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène.

Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 20 kg (soit environ 6 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Posologie

Adultes: La dose initiale recommandée est de 1200 mg - 1800mg par jour en doses fractionnées. Certains patients peuvent être maintenus à 600 mg - 1200mg par jour. La dose quotidienne totale de SAPOFEN ne doit pas dépasser 2400 mg.

///SOLU-MÉDROL Méthylprednisolone

Lyophilisat et solution pour usage parentéral à 20 mg/2 ml, 40 mg/2 ml et 120 mg/2 ml : Flacon de lyophilisat + ampoule autocassable de solvant (2 ml), boîte unitaire

Poudre pour solution injectable à 500 mg : Flacons de poudre, boîte de 10.
Poudre et solvant pour solution injectable à 1 g : Flacon de poudre + flacon de solvant de 15,6 ml, boîte unitaire

Ses indications

Ce médicament est un anti-inflammatoire stéroïdien qui appartient à la famille des corticoïdes de synthèse (dérivés chimiques de la cortisone naturelle). Les propriétés de la cortisone sont nombreuses, mais ce médicament est surtout utilisé pour son effet anti-inflammatoire puissant et rapide. Il présente, à efficacité égale, moins d'effets indésirables que la cortisone naturelle. Il est utilisé

dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques lorsque l'état du malade ne permet pas l'absorption de comprimés, ou lorsqu'un effet rapide est désiré, notamment :

Choc allergique (en complément du traitement par adrénaline, d'action beaucoup plus rapide) ;

Oedème de Quincke (en complément d'un antihistaminique) ;

Etouffement par œdème du larynx (laryngite striduleuse ou suffocante) ;

Oedème du cerveau.

Contre-indications

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- maladies virales en évolution (hépatite, zona, herpès),
- infection ou mycose non contrôlée par un traitement adapté,
- psychose non contrôlée par un traitement,
- prédisposition aux hémorragies (traitement anticoagulant, hémophilie...).

Ces contre-indications peuvent s'appliquer ou ne pas s'appliquer en fonction de la façon dont le médicament est utilisé (injection IM, injection unique ou répétée, degré d'urgence).

Posologie

Solu-Médrol 20 mg et 40 mg :

Après mélange, la solution obtenue peut être administrée directement par voie IM profonde, par voie IV lente (durée minimum : 20 à 30 minutes) ou par perfusion IV après dilution dans une solution isotonique de chlorure de sodium ou de glucose.

Adulte : 20 à 60 mg par jour. Cette dose peut être renouvelée 2 à 3 fois par 24 heures, si nécessaire. Coût du traitement journalier : 1,83 à 5,49 euro(s) (Solu-Médrol 20 mg).

Enfant : 1 à 3 mg/kg/jour. Coût du traitement journalier : 0,092 à 0,27 euro(s)/kg (Solu-Médrol 20 mg).

La solution à 120 mg est réservée à l'adulte.

Elle dépend de la gravité de la maladie traitée.

Conseils

Un traitement prolongé de plus de quelques jours peut nécessiter

*la diminution de la consommation de sel,
la prise de potassium (prescrit par le médecin),
un régime riche en protéines et en calcium, pauvre en glucides.*

///Spasfon

- ❖ *Comprimé enrobé (rose) : Bte de 30, sous plaquettes thermoformées.*
 - ❖ *Solution injectable : Ampoules de 4 ml, boîte de 6.*
 - ❖ *Suppositoire : Boîte de 10, sous plaquettes thermoformées*
- antispasmodique. Il lutte contre les contractions anormales et douloureuses de l'intestin, des voies biliaires, des voies urinaires et de l'utérus.*

INDICATIONS

Comprimé et suppositoire :

-  *Traitement symptomatique des dlrs liées aux tbles $f(x)^{nels}$ du tube digestif et des voies biliaires.*
-  *Trait des manifestations spasmodiques et dlr^{ses} aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.*
-  *Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.*
-  *Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.*

Solution injectable :

-  *Traitement symptomatique des douleurs aiguës liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.*
-  *Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.*
-  *Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës en gynécologie.*

///STEDIRIL

Comment ça marche

Estroprogestatif combiné normodosé, monophasique

Indice de Pearl: 0 pour cent années femmes (17 729 cycles).

L'efficacité contraceptive de STEDIRIL résulte de trois actions complémentaires:

- au niveau de l'axe hypothalamohypophysaire par inhibition de l'ovulation,
- au niveau de la glaire cervicale qui devient imperméable à la migration des spermatozoïdes,
- au niveau de l'endomètre, qui devient impropre à la nidation.

Ses indications Principes actifs Norgestrel , Ethinylestradiol
Contraception hormonale orale.

Sa posologie Prendre régulièrement et sans oubli 1 comprimé bleu par jour au même moment de la journée, pendant 21 jours consécutifs avec un arrêt de 7 jours entre chaque plaquette. Une hémorragie de privation débute habituellement 2 à 3 jours après la prise du dernier comprimé et peut se poursuivre après le début de la plaquette suivante.

///Sulfate de Magnésium

Solution injectable IV à 15 % (0,15 g/ml):Ampoules de 10 ml et 20 ml, btes de 10.

Modèle hospitalier :

Ampoules de 10 ml, boîte de 100.

Ampoules de 20 ml, boîte de 50

Classe thérapeutique :

Anesthésie, réanimation, antalgiques, Métabolisme et nutrition

Indication

-  Traitement curatif des torsades de pointes.
-  Traitement des hypokaliémies aiguës associées à une hypomagnésémie.
-  Apports magnésiens lors de la rééquilibration hydro-électrolytique.
-  Apports magnésiens en nutrition parentérale.
-  Traitement préventif et curatif de la crise d'éclampsie.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Posologie :

Traitement préventif et curatif de la crise d'éclampsie :

En prévention d'une crise d'éclampsie ou lorsque celle-ci se déclare, administrer une perfusion intraveineuse de 16 mmol de magnésium-élément, soit 4 g de sulfate de magnésium heptahydraté, en 20 à 30 minutes.

En cas de persistance de la crise, administrer à nouveau une perfusion intraveineuse de 16 mmol de magnésium-élément, soit 4 g de sulfate de magnésium heptahydraté sans dépasser la dose cumulée maximale de 32 mmol de magnésium-élément, soit 8 g de sulfate de magnésium heptahydraté pendant la première heure de traitement.

Par la suite, perfusion continue de 8 à 12 mmol de magnésium-élément, soit 2 à 3 g de sulfate de magnésium heptahydraté par heure pendant les 24 heures qui suivent la dernière crise.

Mode d'administration :

Injection intraveineuse lente.

Perfusion veineuse, diluée dans une solution glucosée ou saline.

///SURGESTONE

Principes actifs Promégestone

0,5 mg Comprimé blanc Boîte de 10

Comment ça marche

Progestatif de synthèse, dérivé de norpregnane, la promégestone possède le profil biologique suivant :

- *affinité élevée et très spécifique vis-à-vis des récepteurs de la progestérone, supérieure à celle de l'hormone naturelle. Elle forme avec ce récepteur un complexe de longue durée,*
- *compense l'insuffisance en progestérone à des doses 10 à 100 fois inférieures à celle de l'hormone naturelle.*
- *activité anti-estrogénique,*
- *sans activité androgénique et estrogénique.*
- *activité faiblement anti-androgénique et antiglucocorticoïde.*

La promégestone, administrée du 5ème au 25ème jour du cycle à la dose de 0,500 mg par jour en une seule prise, supprime le pic ovulatoire des gonadotrophines, diminue le taux d'estrogènes circulants et empêche la sécrétion de progestérone.

Ses indications

Troubles gynécologiques dus à une insuffisance lutéale :

- *Irrégularité menstruelle due à des troubles de l'ovulation*

- **Dysménorrhée**
- **Syndrome prémenstruel**
- **Mastodynie**
- **Hémorragies fonctionnelles et ménorragies des fibromes**
- **Troubles de la préménopause**
- **Ménopause (en complément d'un traitement estrogénique).**

Sa posologie

Voie orale Réserve à l'adulte.

Respecter strictement les posologies préconisées.

La posologie quotidienne dans l'insuffisance lutéale est en général de 0,125 mg à 0,500 mg par jour en une seule prise du 16ème au 25ème jour du cycle.

Dans le traitement substitutif de la ménopause, l'estrogénothérapie isolée est déconseillée (risque d'hyperplasie de l'endomètre). Dans ce cas, la promégestone doit être prescrite les 12 derniers jours de chaque séquence thérapeutique, suivie d'une interruption de tout traitement substitutif d'une semaine environ au cours de laquelle il est habituel d'observer une hémorragie de privation. La posologie efficace est variable d'un sujet à l'autre. Elle est habituellement de 0,250 mg à 0,500 mg/jour en une seule prise. Elle doit être ajustée individuellement en fonction du tableau clinique, de la posologie de l'estrogène utilisé et de la réponse de la patiente.

///SYNTOCINON

amp5 UI/1 ml Solution injectable

HORMONE POST-HYPOPHYSAIRE

C'est un ocytocique de synthèse, de constitution et de propriétés pharmacologiques identiques à celles de l'hormone ocytocique post-hypophysaire naturelle. Il augmente la fréquence et l'intensité des contractions utérines.

INDICATIONS

- ❖ *Insuffisance des contractions utérines en début ou en cours de travail.*
- ❖ *Chirurgie obstétricale (césarienne, interruption de grossesse...) : obtention d'une bonne rétraction utérine.*
- ❖ *Atonie utérine consécutive à une hémorragie de la délivrance.*

POSOLOGIE

- **Insuffisance des contractions utérines au début ou au cours du travail :**

Perfusion IV lente de 5 UI dans 500 ml de SGI.

La vitesse de perfusion doit être strictement contrôlée et adaptée à la réponse utérine, en commençant par 2 à 8 gouttes/min (correspondant à 1 à 4 MUI ou 0,1 à 0,4 ml/min) avec un maximum de 40 gouttes/min (soit 20 mUI ou 2 ml/min).

A chaque fois que cela sera possible, le rythme de la perfusion sera contrôlé par une pompe de haute précision.

Si les contractions régulières ne sont pas établies après perfusion de 500 ml (soit 5 UI), la perfusion sera interrompue et pourra être rétablie le jour suivant.

- **Chirurgie obstétricale (césarienne, interruption de grossesse...) :**
obtention d'une bonne rétraction utérine :

5 à 10 UI par voie IV lente.

Rarement, en cas de césarienne, la voie intramurale peut être utilisée à la dose de 10 à 15 UI.

- **Atonie utérine consécutive à une hémorragie de la délivrance :**
5 à 10 UI par voie IM ou 5 UI par voie IV lente.

CONTRE-INDICATIONS

- *Hypersensibilité à l'un des composants.*
- *Dystocies.*
- *Frailité ou distension excessive de l'utérus.*
- *Hypertonie utérine ou souffrance foetale quand l'accouchement n'est pas imminent.*
- *Troubles cardiovasculaires et toxémie gravidique sévères.*
- *Prédisposition à l'embolie amniotique (mort foetale in utero, hématome rétroplacentaire).*
- *Placenta prævia.*

INTERACTIONS Méd^{teuses} :

-Certains anesthésiques volatils tels que cyclopropane ou halothane peuvent aggraver l'effet hypotenseur de l'oxytocine et réduire son action utérotonique. En cas d'administration concomitante, des troubles du rythme ont aussi été rapportés.

-Pendant ou après une anesthésie péridurale, l'oxytocine peut potentialiser l'effet vasoconstricteur des sympathomimétiques.

EFFETS INDÉSIRABLES

Rarement : nausées, vomissements, troubles du rythme, coagulation intravasculaire disséminée.

Très rarement, une perfusion trop prolongée de ce médicament peut entraîner un effet antidiurétique qui se manifeste par une intoxication par l'eau transitoire avec céphalées et nausées. Une hyponatrémie est également possible chez le nouveau-né.

Une hypotension immédiate transitoire avec flush et tachycardie réflexe peut être observée après injection intraveineuse rapide.

Exceptionnellement, possibilité de rash, réaction anaphylactoïde, voire de choc anaphylactique.

Après administration IV ou IM, l'oxytocine agit rapidement avec une latence d'action inférieure à 1 minute pour la voie IV et de 2 à 4 minutes pour la voie IM. La réponse utérine dure de 30 à 40 minutes après injection IM, et peut être plus courte après administration IV.

TÉNORMINE®

Comprimé pelliculé sécable à 50 mg et à 100 mg (blanc) : Étuis de 30 et de 90

Solution injectable IV : Ampoules de 10 ml, boîte de 5

Bêtabloquant sélectif

L'aténolol se caractérise par trois propriétés pharmacologiques :

activité bêtabloquante bêta-1 cardiosélective,

effet antiarythmique,

absence de pouvoir agoniste partiel

Voir la fiche de l'Atenolol

///TERGYNAN

Comprimé vaginal : Boîte de 10, sous film thermosoudé

Ce médicament contient un antiparasitaire de la famille des imidazolés, un antibiotique de la famille des aminosides et un antifongique.

Il est utilisé dans le traitement local des infections vaginales, notamment celles à trichomonas, et les mycoses.

Substances actives : Métronidazole, Néomycine sulfate, Nystatin

OSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Réservé à l'adulte, Voie vaginale.

Vaginites à germes sensibles et vaginites non spécifiques : 1 cp vaginal 1 à 2 fois par jour pendant 10 jours consécutifs, en association avec un trait par voie orale si nécessaire. Mouiller le comprimé en le trempant dans l'eau pendant 20 à 30 secondes avant de le mettre en place. Rester ensuite allongée pendant un quart d'heure environ.

Il est impératif de traiter simultanément le partenaire, qu'il présente ou non des signes cliniques.

Un traitement par le métronidazole ne doit pas être prescrit pendant plus de 10 jours et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.

Conseils pratiques :

Le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales, le port de tampon interne pendant le traitement...) et, dans la mesure du possible, de la suppression des facteurs favorisants. Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

TRAMADOL

Antalgique opiacé faible : formes sèches

50 mg : comprimé ; boîte de 30.

100 mg ; 150 mg ; 200 mg cp LP

50 mg sol inj

INDICATIONS

Traitement des douleurs modérées à intenses de l'adulte.

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION

Douleurs aiguës : La dose d'attaque est de 100 mg (2 comprimés) suivie de 50 ou 100 mg (1 ou 2 comprimés) toutes les 4-6 heures sans dépasser 400 mg/24 h

(8 comprimés).

Douleurs chroniques : La dose d'attaque est de 50 ou 100 mg (1 ou 2 comprimés) suivie de 50 ou 100 mg (1 ou 2 comprimés) toutes les 4-6 heures sans dépasser 400 mg/24 h (8 comprimés).

- A partir de 75 ans, il est recommandé d'augmenter l'intervalle entre les prises (toutes les 9 heures).

- En cas d'insuffisance hépatique : réduire la dose unitaire de moitié ou augmenter de 2 fois l'intervalle entre les prises (toutes les 12 heures).

- En cas d'insuffisance rénale : augmenter de 2 fois l'intervalle entre les prises (toutes les 12 heures pour une clairance de la créatinine < 30 ml/min).

Eviter d'utiliser le tramadol si la clairance de la créatinine est < 10 ml/min.

CONTRE-INDICATIONS

Absolue(s) :

Hypersensibilité aux opiacés

Intoxication par les dépresseurs du système nerveux central

Insuffisance respiratoire sévère

Insuffisance hépatique sévère

Enfant de moins de 15 ans

Allaitement

Epilepsie non contrôlée

Relative(s) : Grossesse

///Utrogestan

Ce mdct contient une hormone naturelle, la progestérone.

- ❖ Capsule molle orale ou vaginale à 100 mg (ivoire) : Boîte de 30, sous plaquette thermoformée.
- ❖ Capsule molle orale ou vaginale à 200 mg (ivoire) : Boîte de 15, sous plaquette thermoformée.

INDICATIONS

Voie orale :

Troubles liés à une insuffisance en progestérone, en particulier :

-  Syndrome prémenstruel.
-  Irrégularités m^{enstruelles} par dysovulation ou anovulation.

- ✚ Mastopathies bénignes.
- ✚ Préménopause.
- ✚ Traitement substitutif de la ménopause (en complément du traitement estrogénique).

Voie vaginale :

- ✚ Substitution en progestérone au cours des insuff^{ces} ovariennes ou des déficits complets des femmes ovarioprives (dons d'ovocytes).
- ✚ Supplémentation de la phase lutéale au cours des cycles de fécondation in vitro (FIV).
- ✚ Supplémentation de la phase lutéale au cours de cycles spontanés ou induits, en cas d'hypofertilité ou de stérilité primaire ou secondaire, notamment par dysovulation.
- ✚ En cas de menace d'avortement ou de prévention d'avortement à répétition par insuffisance lutéale, jusqu'à la 12e semaine de grossesse.

Dans toutes les autres indications de la progestérone, la voie vaginale représente une alternative à la voie orale en cas d'effets secondaires dus à la progestérone (sommolence après absorption par voie orale).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

la posologie ne devra pas dépasser 200 mg par prise.

Voie orale :

- Dans les insuffisances en progestérone, la posologie moyenne est de 200 à 300 mg de progestérone micronisée par jour. à distance des repas, de préférence le soir au coucher.
- Dans les insuffisances lutéales (syndrome prémenstruel, mastopathies bénignes, irrégularités menstruelles, préménopause) :
Le schéma thérapeutique habituel est de 200 à 300 mg par jour :
soit 200 mg en 1 prise le soir au coucher,
soit 300 mg en 2 prises,
10 jours par cycle, habituellement du 17e au 26e jour inclus.
- Dans le traitement substitutif de la ménopause :
L'estrogénothérapie isolée est déconseillée (risque d'hyperplasie de l'endomètre).

*On adjointra de la progestérone à raison de 200 mg par jour :
en 2 prises de 100 mg chacune,
ou en 1 seule prise de 200 mg le soir au coucher,
soit 12 à 14 jours par mois, soit les 2 dernières semaines de chaque séquence thérapeutique.*

Ce traitement sera suivi d'une interruption de tout traitement substitutif pendant une semaine environ, au cours de laquelle il est habituel d'observer une hémorragie de privation.

NB *Pour ces indications, on utilisera la voie vaginale, aux mêmes posologies que la voie orale, en cas d'effets secondaires dus à la progestérone (somnolence après absorption orale).*

Voie vaginale :

Chaque capsule doit être insérée profondément dans le vagin.

-Substitution en progestérone au cours des insuffisances ovariennes ou des déficits complets des femmes ovarioprives (dons d'ovocytes) :

Le schéma thérapeutique (en complément d'un traitement estrogénique approprié) est le suivant :

100 mg de progestérone micronisée par jour les 13e et 14e jours du cycle de transfert, puis

200 mg de progestérone micronisée par jour du 15e au 25e jour du cycle, répartis en 1 ou 2 prises par jour, puis

à partir du 26e jour du cycle et en cas de grossesse débutante, cette dose peut atteindre au maximum 600 mg par jour répartis en 3 prises. Cette posologie sera poursuivie jusqu'au 60e jour et, au plus tard, jusqu'à la 12e semaine de grossesse.

-Supplémentation de la phase lutéale au cours des cycles de FIV :

La posologie recommandée est de 400 à 600 mg par jour, en 2 à 3 prises par jour, à partir du jour de l'injection d'hCG jusqu'à la 12e semaine de grossesse.

-Supplémentation de la phase lutéale au cours des cycles spontanés ou induits, en cas d'hypofertilité ou de stérilité primaire ou secondaire, notamment par dysovulation :

La posologie conseillée est de 200 à 300 mg par jour, en 2 prises, à partir du 17e jour du cycle pendant 10 jours. Le traitement sera repris rapidement en cas

d'absence de retour des règles et de diagnostic de grossesse, jusqu'à la 12e semaine de grossesse.

-Menace d'avortement précoce ou prévention d'avortement à répétition par insuffisance lutéale :

La posologie recommandée est de 200 à 400 mg par jour en 2 prises, jusqu'à la 12e semaine de grossesse.

CONTRE-INDICATIONS

En cas d'altérations graves de la fonction hépatique.

///VIBRAMYCINE Doxycycline monohydrate

100 mg cp sécable (jaune pâle) bte de 5

100 mg cp sécable (jaune pâle) bte de 30

Ses indications

C'est un antibiotique qui appartient à la famille des cyclines.

Il est utilisé dans le traitement :

- . de diverses maladies infectieuses, notamment des poumons, des bronches, des yeux, des voies urinaires et génitales ;*
- . de l'acné et de certaines formes de rosacée.*

Contre-indications

- ❖ *Allergie aux cyclines.*
- ❖ *Enfant de moins de 8 ans (risque de coloration définitive des dents).*
- ❖ *En association avec les rétinoïdes par voie orale.*
- ❖ *Grossesse (à partir du 4e mois).*

Posologie

Adulte de plus de 60 kg : 2 comprimés à 100 mg par jour, en une prise.

Adulte de moins de 60 kg : 2 comprimés à 100 mg en une prise le 1er jour, puis 1 comprimé à 100 mg par jour.

Enfant de plus de 8 ans : 4 mg par kg et par jour en une seule prise.

Effets indésirables

Nausées, diarrhée, douleurs de l'estomac, manque d'appétit, inflammation de la bouche.

Candidose, réaction allergique, photosensibilisation

Conseil Les médicaments contenant de la doxycycline exposent à un risque de lésion en cas de contact prolongé avec la muqueuse (revêtement interne) de l'œsophage. Ils doivent donc être pris avec une quantité d'eau suffisante (un verre entier) pour descendre jusqu'à l'estomac. Pour la même raison, il est déconseillé de prendre ce médicament en position allongée ou juste avant le coucher.

Ce antibiotique est photosensibilisant : une exposition, même de courte durée, aux rayons ultraviolets peut provoquer des coups de soleil intenses.

///VOGALÈNE

Vogalène Lyoc : Lyophilisat oral à 7,5 mg : Boîte de 16, sous plaquettes thermoformées.

Vogalène : Gélule à 15 mg (opaque ; blanche) : Boîte de 20, sous plaquettes thermoformées. Solution buvable à 0,1 % : Flacon de 150 ml + seringue pour administration orale graduée en kg de poids de l'enfant (de 2 à 15 kg).

Solution buvable à 0,4 % : Flacon de 30 ml (1200 gouttes), avec compte-gouttes.

Solution injectable à 10 mg/1 ml : Ampoules de 1 ml, boîte de 10. Suppositoire sécable à 5 mg : Boîte de 10, sous plaquettes thermoformées

Ce médicament est un antiémétique qui appartient à la famille des phénothiazines. Il régularise la contraction des muscles de l'œsophage et de l'estomac.

Il est utilisé pour traiter les nausées et les vomissements.

La forme injectable est également utilisée pour prévenir les vomissements provoqués par les chimio^{piés} anticancéreuses.

Contre Indication Glaucome à angle fermé, Risque de rétention urinaire lié à un adénome de la prostate.

Posologie usuelle

Lyophilisat oral :

- Adulte : 1 lyophilisat, 2 à 4 fois par jour.
- Enfant de 6 à 12 ans : 1 lyophilisat, 1 ou 2 fois par jour.

Gélules :

- Adulte : 1 gélule, 1 ou 2 fois par jour.

Solution buvable à 0,1 % :

- *Adulte : 1 ou 2 cuillères à café, 1 à 3 fois par jour.*
- *Enfant de 6 à 12 ans : ½ à 1 cuillère à café, 1 à 3/jour.*
- *Enfant de moins de 6 ans : 1 seringue remplie jusqu'à la graduation du poids de l'enfant, 1 à 3 fois par jour.*

Solution buvable à 0,4 % :

- *Adulte : 150 à 300 gouttes par jour.*
- *Enfant de 6 à 12 ans : 75 à 150 g^{tt}es / j, à répartir dans la journée.*
- *Enfant de moins de 6 ans : 10 gouttes /kg/j.*

Suppositoires :

- *Adulte : 3 à 6 sup/ j, à répartir en 3 prises.*
- *Enfant de 6 à 12 ans : ½ à 1 sup x 3 /j*
- *Enfant de moins de 6 ans : 1 sup/5kg/j, à répartir en 3 prises.*
Exemple, pour un enfant de 8 kg : ½ suppositoire, 3 fois par jour.

le syndrome HELLP est une complication grave de pré-éclampsie chez la femme enceinte caractérisée par une forte diminution des globules rouges (anémie hémolytique) et des plaquettes sanguines (thrombopénie) avec une défaillance du foie (cytolyse hépatique). Le syndrome HELLP se produit généralement durant les derniers stades de la grossesse mais parfois aussi après l'accouchement. Il nécessite une prise en charge hospitalière, le seul traitement efficace étant l'extraction fœtale.

